

16 - tec kamla

Bonjour et bienvenue dans ce cours qui poursuit les généralités en matière de communication scientifique. Les objectifs de ce cours vont être de se familiariser avec les concepts clés de la communication scientifique, savoir situer la communication scientifique dans le cadre du processus de recherche, savoir argumenter l'intérêt et l'importance de la communication scientifique dans le domaine médical, lister les différents moyens et types de communication scientifique, décrire le contenu du rapport d'études et enfin relater les objectifs de la communication scientifique. Pour le plan, nous allons commencer par l'introduction puis nous allons discuter pourquoi communiquer.

Nous allons également parler des types et moyens de communication avant de donner plus de détails sur le rapport d'études et de parler des objectifs de la communication et des défis en rapport à ce fait avec ces objectifs. Le savoir scientifique, c'est un savoir qui est en perpétuelle évolution et le but de la recherche, c'est de produire des connaissances qui vont nous permettre d'apporter des changements à nos pratiques. L'exemple type, c'est pour traiter les médicaments.

Nous devons faire des recherches pour comprendre les maladies, pour découvrir de nouveaux traitements, pour initier le changement, le changement va être de prescrire ces traitements pour améliorer la santé des patients. Donc, ça c'est l'objectif de manière générale de la recherche et dans ce cadre-là, la communication est une activité clé parce qu' imaginez que nous faisons tous ces efforts de recherche, de découverte, mais on ne les communique pas. Comment est-ce que le changement va être opéré ? Donc la communication est une activité importante dans le domaine scientifique, dans le domaine médical pour diffuser les connaissances qui sont découvertes.

On peut définir la communication scientifique comme une activité qui a pour objectif de diffuser les problématiques et les résultats de la recherche scientifique, qu'elles soient fondamentales ou appliquées. L'objectif de la communication scientifique, c'est de faire une communication claire et précise du savoir scientifique et donc on va être en relation étroite et intime avec la méthode scientifique elle-même qui est claire, précise et très recoureuse. Je vous rappelle rapidement la méthode scientifique.

On commence par des observations qu'on fait sur notre terrain, au milieu de pratiques. On fait des observations soigneuses. On se pose des questions pertinentes par rapport à ces observations que nous avons faites.

Puis on propose des hypothèses explicatives de ce que nous avons observé. A partir de ces hypothèses, nous pouvons imaginer ou avoir une idée sur les prédictions de résultats. Nous passons après à une observation, à faire des observations sur le terrain.

A partir de ces observations, on va collecter des données. Ceci va nous permettre de vérifier les

hypothèses et bien sûr de revenir, c'est une sorte de boucle ou de cycle, revenir à partir de ce que nous avons retrouvé comme résultat, on passe à une nouvelle observation de notre réalité et ainsi de suite. Ce processus-là résume en quelque sorte la méthode scientifique qui est marquée par cette observation minutieuse, cette rigueur et cette logique dans son environnement.

Par rapport à la conduite de ces activités de recherche, comment est-ce qu'on peut placer la communication scientifique ? Comme vous le voyez sur cette diapo, on a tout en haut la définition de la question de recherche, après la formulation des hypothèses, après on va recueillir les données, analyser, interpréter les données et les résultats et enfin c'est à ce moment-là qu'on doit communiquer les résultats de notre travail. Il vient à la fin du processus de recherche. Ce schéma permet de décrire la logique de progression des connaissances dans le domaine scientifique.

Regardez la deuxième ligne, on commence par choisir la question qu'on veut étudier. On développe un protocole de recherche, on mène l'étude, on analyse les données, on rapporte l'étude. C'est très logique et simple par rapport à un seul travail de recherche.

Mais maintenant, comment est-ce que ce travail de recherche est situé, est placé, comment est-ce qu'on utilise les autres connaissances ? Déjà quand nous développons notre étude, regardez, lorsqu'on développe un protocole, nous allons utiliser les données existantes. Dans toute cette étape-là, lorsque nous développons notre protocole et menons notre étude, et nous analysons pour interpréter les résultats, nous allons utiliser les données existantes pour comprendre ce que nous voulons faire et pour comparer avec ce que les autres ont fait. Donc ça, c'est l'utilisation des données qui existent déjà, on appelle ça la revue de la littérature.

Et puis lorsque nous rapportons notre étude à la fin de notre travail, notre travail lui-même va contribuer à un progrès dans le domaine des connaissances qui existent de manière générale et va constituer une partie de ces connaissances qui existent et va nous permettre de décider quelles sont les nouvelles questions à étudier ou les éléments qui n'ont pas encore été éclaircis ou évalués. Et c'est comme ça qu'on peut progresser dans les connaissances scientifiques. Pourquoi communiquer dans le domaine médical ? Première justification, c'est qu'il s'agit d'une étape logique de toute recherche, c'est ce que nous étions en train de discuter.

Lorsqu'on fait un travail de recherche et on analyse des données, la suite logique c'est de communiquer et de diffuser ces résultats pour contribuer à la progression de la science. Il y a un deuxième argument, une deuxième justification, c'est une fonction comptable que cette communication va jouer, ce que nous devons rendre compte à nos institutions, aux chercheurs, nous devons rendre compte aux décideurs et aux dirigeants politiques comme le ministère de la Santé qui a besoin de données pour mettre en place des politiques, nous rendons compte aux organismes financeurs qui nous donnent des financements pour mener les travaux de recherche, nous rendons compte également au public et à la société qui a confiance en nous en tant que scientifiques pour faire avancer les choses et améliorer la santé et le bien-être, et enfin nous

avons des comptes à rendre envers les autres collègues, les autres scientifiques et la communauté scientifique de manière générale. Quelles sont les conséquences de la communication scientifique pour les chercheurs ? Les conséquences peuvent se voir sous forme de promotion dans notre travail, de diplômes que nous obtenons et l'exemple type c'est lorsque vous faites votre thèse de médecine pour obtenir le diplôme des études médicales.

Les conséquences peuvent se voir sous forme d'un brevet, donc en communiquant la recherche pour obtenir des brevets, pour le renouvellement d'un financement ou d'un contrat de travail, et suite à la requête d'un décideur, par exemple lorsque le ministère de la Santé demande à des chercheurs, des médecins, de mener un travail de recherche et de lui donner des résultats à utiliser pour la prise de décision. Les méthodes de communication scientifique sont là pour nous permettre de passer d'une étude que nous avons réalisée, de résultats que nous avons obtenus, de connaissances que nous avons générées, pour les transmettre à des interlocuteurs qui peuvent être variés, dans des contextes variés, mais le plus important c'est qu'on voudrait leur transmettre ces informations pour une certaine utilité, c'est-à-dire pour qu'ils comprennent ces informations, qu'ils les utilisent à bon escient. Donc en ce qui concerne ces interlocuteurs, nous avons deux cibles différentes dans notre domaine en tant que scientifiques, en ce qui concerne la communication scientifique.

Donc lorsqu'on est face à un public de scientifiques ou de professionnels, nous allons utiliser un type de communication technique par opposition à la situation où nous avons face à nous le grand public, où nous voulons communiquer des aspects scientifiques avec le grand public, nous allons devoir utiliser un langage ou un type de communication vulgarisée pour que nous puissions faire comprendre ce que nous voulons à notre interlocuteur. En ce qui concerne le niveau de formalisation, lorsqu'on est face à un public scientifique, on va avoir un niveau de formalisation plus important par rapport à lorsqu'on est face à un grand public. Et bien sûr, dans deux situations, il faut préciser que nous sommes à la recherche de l'efficacité, nous voudrions que notre message parvienne à nos interlocuteurs, n'importe quelle qu'elle soit la catégorie de notre cible.

Tout simplement, lorsqu'on sépare les deux cibles, il faut savoir qu'on est devant des attentes et des besoins différents, ce qui fait qu'on va utiliser des méthodes et un type de communication qui sont différents. Pour prendre un exemple pratique, avec la pandémie de Covid qui a marqué l'année 2020 et ça continue avec l'année 2021, on sait qu'il y a une communication technique avec les médecins, les scientifiques, dans la communauté des chercheurs de manière générale, et puis il y a une communication très importante qui est une communication de vulgarisation avec le grand public et qui a commencé depuis le début de la pandémie et qui continue jusqu'à maintenant. Pour un futur médecin, quelles sont les situations de communication scientifique ou technique qui peuvent se présenter ? Déjà, tout au long des études, les jeunes étudiants en médecine, les futurs médecins vont devoir présenter des cas lors des visites médicales ou des staff multidisciplinaires.

Ils vont utiliser la communication technique pour présenter ces cas parce qu'ils sont dans un cadre professionnel et ils ont un public de professionnels et de spécialistes, donc ils vont utiliser une communication technique. Il y a d'autres occasions où ils vont utiliser la communication technique ou scientifique, surtout lorsqu'ils vont rédiger la thèse. Le premier projet de recherche avec un rapport de recherche, c'est la thèse de médecine.

Ils vont faire la rédaction de la thèse, c'est un document écrit, après ils vont faire la soutenance de la thèse, c'est une communication orale. Et puis, bien sûr, les futurs médecins participent à des congrès, des réunions scientifiques, et même après l'intégration de la vie professionnelle, ils peuvent participer à l'enseignement, à l'encadrement d'autres professionnels ou étudiants. Quels sont les moyens de communication qui sont disponibles à nous ? Il y en a plusieurs, il y a les revues scientifiques ou professionnelles, principalement pour les médecins.

Il y a les congrès nationaux et internationaux, les pages web, la télé, la radio, les journaux d'information générale et les magazines. Comme vous voyez ici, il y a des moyens de communication qui sont spécifiques et puis des moyens de communication qui sont généraux à la population générale. Il faut savoir qu'avec l'explosion d'Internet et l'utilisation de nouvelles technologies d'information, bien sûr, tout ça a beaucoup changé au cours des dernières années.

On continue à avoir les revues, les congrès, etc., mais il y a une place importante actuellement jouée par Internet, où on trouve énormément d'informations scientifiques et techniques. On peut parler également de deux grands types de communication, d'un côté la communication écrite et de l'autre la communication orale. Dans la communication écrite, on peut décrire les rapports d'études.

Ce sont des rapports qui permettent de résumer le travail qui a été fait, de décrire son déroulement et ses résultats. Ça permet la pérennité de l'information et ça engage bien sûr la responsabilité et le devoir du chercheur qui rédige ce rapport, dans lequel il rapporte tout ce qu'il a fait en ce qui concerne cette étude. Et bien sûr, il traduit sa rigueur scientifique et son honnêteté dans le travail qui a été fait.

Le deuxième type, c'est l'article scientifique, toujours dans la communication écrite, c'est l'article scientifique original. Il ressemble aux rapports d'études, mais il a un format très particulier, c'est le format qu'on va publier dans les revues scientifiques. L'article scientifique original, une fois il est publié, ça veut dire souvent qu'il a reçu la validation par la communauté scientifique.

Et cela se passe à travers l'évaluation par les pairs, c'est-à-dire l'évaluation par d'autres experts qui s'intéressent à la thématique de l'article, qui vont l'évaluer pour dire qu'on pense que les résultats semblent être valides et sont d'un intérêt pour la communauté scientifique. C'est après ce moment-là que ces articles sont publiés. Pour la communication orale, en général ça se passe dans les congrès scientifiques, les conférences professionnelles.

C'est la première occasion pour diffuser les résultats et là pour avantage d'avoir un auditoire captif avec l'originalité de la première communication. Cela nous permet d'obtenir le feedback d'autres scientifiques pour améliorer notre travail avant de passer à une publication par article. Dans ce rapport d'études qu'on a évoqué dans la diapo précédente, c'est un exposé dans lequel on va relater tout ce qu'on a fait pour répondre à la question de recherche.

Retenez bien les quatre principaux éléments qui figurent dans le rapport d'études. Premièrement, la question qu'on s'est posée. Deuxièmement, les éléments qui nous ont permis de répondre à cette question.

Troisièmement, la réponse que nous avons trouvée à la question. Et troisièmement, l'interprétation raisonnable de cette réponse. En d'autres termes, la question qu'on s'est posée, c'est l'objectif qui va figurer dans l'introduction.

C'est l'objectif pourquoi nous faisons cette étude. Et la question qu'on s'est posée. Les éléments qui ont permis de répondre à la question, en d'autres termes, c'est la méthodologie du travail qui a été faite.

La réponse à la question, ce sont les résultats. Et enfin, l'interprétation qu'on fait de la réponse ou des résultats, c'est la discussion. Donc retenez bien ces éléments, on va en parler plus lentement dans le futur.

Dans ce tableau, sont listés différents types de documents de rapport d'études, avec le support qui peut être utilisé, leur diffusion, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est limité ou variable, et les limites de ce type de documents. Donc, comme on a déjà parlé des articles scientifiques, on peut commencer par ceux-là. Donc, les articles, souvent, ils ont un support papier, quoique, au cours des dernières années, tous les articles sont disponibles au format électronique, avec, comme on a dit, Internet qui prend de plus en plus de place.

La diffusion, en général, elle est grande, mais les limites, c'est le délai de publication et le coût de publication, que ce soit pour le format papier ou pour le format en ligne actuellement. Les autres rapports, alors les rapports, c'est comme les thèses de médecine, donc le support qu'on utilise, c'est le support papier. Là aussi, au niveau de beaucoup de facultés, comme notre faculté, il y a un format électronique qui est disponible.

La diffusion est limitée, en général, puisque ça se limite aux personnes qui sont intéressées, qui ont été touchées par ces documents. Il y a une absence de validation, à la différence des articles scientifiques originaux, et l'obsolescence est rapide, c'est-à-dire que ces documents vont devenir anciens très vite. Les livres, on les connaît tous, format papier avec une diffusion qui est variable, mais ils ont un problème en rapport avec le délai de publication et le coût de publication.

Les formats électroniques ou les supports électroniques qu'on va retrouver pour les pages web, les CD ou les DVD, ils prennent, bien sûr, de plus en plus d'ampleur, surtout en ce qui concerne

les pages web. Donc, il faudra aussi savoir utiliser, juger ou évaluer la qualité, puisque le problème, c'est la qualité variable pour ces supports. Nous passons maintenant à la discussion des objectifs de la communication scientifique et qui sont en nombre de trois.

L'accessibilité, la compréhensibilité et la crédibilité. En ce qui concerne l'objectif d'accessibilité, il concerne le public qui est intéressé par notre étude ou par le contenu de notre communication. Il importe de poser la question, qui voulons-nous toucher par cette information ? Quels sont les utilisateurs potentiels de ces données ? C'est comme ça que nous pouvons choisir notre public, de telle sorte à transmettre de manière efficace notre message.

Et bien sûr, le choix du public va nous guider pour la méthode de la communication pour être le mieux compris par ce public. Le deuxième objectif concerne la compréhensibilité de l'information communiquée. Pour atteindre cet objectif, il faut utiliser un langage et une structure adaptées au type du lecteur ciblé.

Et bien sûr, le niveau de technicité du langage qu'on va utiliser va être dépendant de notre public. En général, il est recommandé d'éviter d'utiliser des rapports trop techniques avec un jargon spécialisé, sauf si on s'adresse bien sûr à un public d'experts. Le troisième objectif, c'est la crédibilité.

Cet objectif est un rapport avec la rigueur scientifique. Dès le début de notre étude et tout au long de l'étude, il faut qu'on suive de manière rigoureuse la méthodologie scientifique, ce qui va donner de la crédibilité à notre travail. Un deuxième élément en rapport avec la crédibilité, c'est l'interprétation des auteurs.

L'interprétation dont on a parlé quand on fait des résultats que nous avons trouvés, il faut qu'elle soit basée sur les arguments scientifiques, sur les observations, sur les données réelles. Il faut éviter nos propres opinions et leur influence sur notre recherche et notre communication. En résumé, nous avons parlé de trois objectifs de la communication, l'accessibilité, la compréhensibilité et la crédibilité.

Quelles sont les implications de ces objectifs ? On les trouve résumés dans ce tableau. Les implications sont de deux types, des implications logiques et des implications de style. Pour être accessible, il faut penser à la diffusion.

Où est-ce qu'on va diffuser ? Comment on va diffuser notre travail ? En ce qui concerne le choix du support, ça va dépendre de la situation de communication. Est-ce qu'on est dans une communication orale ou une communication écrite ? Les implications de style pour l'accessibilité sont la concision, lorsqu'on écrit, le lacunisme à l'oral, c'est-à-dire le fait de ne pas répéter inutilement des idées, et la fluidité de notre style, c'est-à-dire que les idées se succèdent de manière facile pour le lecteur ou le public pour nous suivre. La compréhensibilité a comme implication logique la simplicité, donc ce que nous communiquons doit être simple, et en termes de style doit être clair, c'est-à-dire nous apportant des informations qui sont rédigées ou

présentées de manière claire.

Et enfin, l'objectif de crédibilité, il implique la rigueur comme on l'a dit, l'intégrité scientifique, et en matière de style, il implique la précision, donc plus on est précis, plus on va être crédible face à notre public. Les supports qu'on peut utiliser pour communiquer dans le domaine scientifique, peut-être soit de type papier comme les articles, les livres, les rapports, les thèses ou les mémoires qu'on appelle aussi les monographies non publiées, ils peuvent être aussi électroniques comme les pages internet ou les CD ou les DVD ou tout autre support électronique. Dans le cadre de la communication scientifique, l'échonographie est très importante, il faut toujours penser à enrichir le texte avec les tableaux, les figures, les images, surtout très tout récemment avec l'utilisation des nouvelles technologies de la formation, le son et l'image ont une importance capitale dans les médias électroniques.

Pour donner des éléments en ce qui concerne le style en pratique, on dit qu'il faut en matière de style respecter la position forte, ça veut dire quoi ? C'est la position au début du paragraphe, au début du titre, utiliser les mots-clés dans cette position forte qui va permettre de retenir l'attention du lecteur, utiliser la ponctuation de manière générale de bonne façon pour permettre au lecteur de comprendre le sens de notre discours, utiliser les temps de verbe d'une bonne façon, en général on dit que le passé va être utilisé pour tous les événements survenus dans le passé, comme la partie méthodologie lorsqu'on décrit ce que nous avons fait dans notre étude, la partie résultats lorsqu'on décrit les résultats que nous avons obtenus, et le présent va être utilisé pour ce qu'on appelle les vérités scientifiques, c'est-à-dire quelque chose qui est connu actuellement, établi, on peut dire qu'il est très fréquent de voir tel ou tel phénomène, que la prévalence du diabète est 2, parce que ça, ça concerne des informations ou des données qui sont considérées comme étant des vérités scientifiques. Alors quels sont les challenges auxquels on peut faire face en étant des professionnels de santé, des scientifiques, dans le cadre de cette communication ? La communication en général survient suite à un processus lent et laborieux, quand on fait un travail de recherche, on a des échéances, c'est-à-dire des délais à respecter, on est fatigué de ce travail lent et on a envie de passer à autre chose, et c'est pour ça que c'est une activité qui est difficile pour les chercheurs, surtout lorsqu'on est à la fois chercheur et professionnel de santé, d'où l'intérêt de maîtriser la communication scientifique. Lorsqu'on maîtrise les techniques de la communication scientifique, ça va nous faciliter la tâche pour cette pratique.

Donc quelles sont les aptitudes nécessaires et qu'on devrait apprendre pour bien communiquer dans notre domaine ? Il y a des compétences techniques en matière de rédaction et de gestion de l'information, on peut apprendre comment rédiger, mais aussi comment gérer l'information, comment faire les analyses et l'interprétation des données. Il faudrait aussi développer une réflexion structurée et critique, qui est très importante dans le domaine scientifique, il faut maîtriser la langue, surtout l'anglais qui est la langue de la science actuellement, et puis utiliser et maîtriser différentes méthodes ou modes de communication en fonction de notre audience ou

notre public, et aussi en fonction des objectifs de notre communication. Les messages clés que je voudrais qu'on retienne ensemble à partir de ce cours, c'est qu'une étude n'est pas finie tant que ses résultats ne sont pas communiqués, donc la communication est une étape logique de la recherche comme on l'a dit, la communication écrite garantit la pérennité, parce que l'information va être notée au niveau d'un document, la publication d'un article est une garantie de sa validation, parce qu'on a dit qu'il va être évalué par des pairs, d'autres personnes qui sont expertes dans le domaine, le choix du format et des exigences de style doivent répondre aux objectifs, donc je rappelle les trois objectifs importants qu'il faut retenir et maîtriser, à savoir l'accessibilité, la compréhensibilité et la crédibilité.

Donc, apprendre les méthodes de communication scientifique est très important pour nous permettre d'atteindre notre objectif de diffusion efficiente et de communication efficace des résultats de notre âme. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour et bienvenue dans ce cours qui va porter sur l'article original.

Dans cette première partie, on va parler de la structure générale de l'article. Les objectifs de ce cours vont être de reconnaître la structure de l'article scientifique, de décrire le contenu des différentes sections, de discuter les particularités de chaque section et enfin de relater les erreurs à éviter lors de la rédaction. Le plan que nous allons suivre va consister en une introduction.

Après, nous allons présenter la structure générale, à savoir la structure EMRED. Nous allons parler du titre de l'article pour après détailler les différentes sections, à savoir l'introduction, les méthodes, les résultats et la discussion. Il faut savoir qu'il y a différents types d'articles médicaux, dont l'article original dont on va parler aujourd'hui.

Il y a d'autres types d'articles comme l'éditorial, l'article didactique, l'électro-éditeur. Tout ça, c'est différents types d'articles médicaux qui vont être utilisés en fonction du besoin et de l'objectif de l'auteur. L'article original, c'est l'article qui rapporte les résultats d'une étude qu'on appelle originale, c'est-à-dire une étude qui a consisté à faire un travail de recherche, à collecter des données.

L'article original va présenter les résultats de cette étude. C'est un type d'article très répandu, très important dans le domaine de la recherche scientifique, mais aussi de la communication scientifique. Quand on est face à l'exercice de rédaction de l'article original, quels sont les enjeux stratégiques ? Il faut déjà définir le public cible, et ça, nous en avons parlé lorsqu'on a parlé de manière générale de la communication scientifique.

Définir les objectifs de la communication. Qu'est-ce que nous cherchons à atteindre comme objectif ? Définir le message. Qu'est-ce que nous voulons transmettre ? Et enfin, travailler, insister sur la qualité de la rédaction de manière générale pour véhiculer notre message et atteindre les objectifs de communication auprès de notre public cible.

Alors, qu'est-ce que nous devons faire avant la rédaction ? Déjà, il faut se mettre d'accord sur les

auteurs. Cette équipe qui travaille sur l'article, il faut identifier les différents auteurs et se mettre d'accord sur le rôle de chacun. Se répartir les tâches de rédaction en fonction des rôles de chacun et des compétences de chacun.

Choisir la revue. Consulter des exemplaires de la revue pour avoir une idée sur les exigences de la rédaction. Il ne faut pas hésiter à s'inspirer d'articles de très bonne revue pour pouvoir rédiger soi-même des articles de bonne qualité.

Fixer un échantillon et préparer la bibliographie. Donc, la bibliographie, c'est tous les articles et les références que nous allons utiliser pour argumenter notre texte. Maintenant, nous allons parler de la structure générale de l'article qu'on appelle, en utilisant l'abréviation IMRAD, c'est en anglais, Introduction, Methods, Results and Discussion.

En français, on dit IMRAD avec un E pour dire c'est introduction, matériel, méthode, résultat et discussion. Donc, c'est une structure générale qui est connue à l'échelle internationale au sein de la communauté scientifique qu'on utilise pour présenter les résultats des études sous forme d'articles originaux. Donc, on va présenter en premier les titres, la liste des auteurs et leur affiliation, c'est-à-dire leur milieu de travail, université, institut de recherche, etc.

On va trouver le résumé de notre article. Après, il y a les quatre sections que vous voyez en rouge, les sections de l'article qui commencent par l'introduction, matériel et méthode, résultat et discussion. Si vous vous rappelez, je vous ai parlé de ces quatre sections dans le rapport d'études.

C'est la continuité de ce que nous avons vu. Après, on trouve les références. On peut trouver d'autres sections comme les remerciements, la déclaration des comptes d'intérêt, en fonction des situations et en fonction des exigences des reclus.

Pour ce qui est du titre, c'est un élément très important de l'article. On dit que c'est la vitrine de l'article. Le titre va renseigner le lecteur sur l'article et c'est une étape importante pour convaincre le lecteur de lire nos articles.

Donc, des recommandations par rapport au titre, il faut qu'il soit court mais en même temps précis. Il peut être plus ou moins lent si on cherche à être précis et à véhiculer l'information de manière précise. Le titre peut être informatif ou indicatif.

Informatif va donner l'information directement. Indicatif donne tout simplement une idée, une indication sur ce qu'il y a dans l'article pour laisser le lecteur découvrir. C'est un choix qu'on peut faire en fonction de chaque situation.

Il ne doit pas être interrogatif. Il n'est pas recommandé d'utiliser une interrogation même si ça se fait de temps en temps. Il ne doit pas contenir de vain et il doit contenir l'idée principale.

Ça, c'est le critère le plus important. Il faut que l'idée principale de l'article soit transmise dans le titre et il faut respecter le principe de la position forte. Ça veut dire quoi ? Je vais utiliser les mots-clés, les éléments importants de mon article ou les idées importantes de mon article au début du titre pour attirer l'attention.

Si on prend l'exemple de ce titre, c'est un article, je vous ai mis la référence en bas. C'est un article en anglais, mais que j'ai traduit en français. Je vous invite à examiner ce titre et à voir s'il respecte les critères, les recommandations qu'on vient de voir ou pas.

Ici, je vais vous donner un titre d'exemple, des éléments à analyser et qu'on pourra discuter ensemble lors de la séance interactive. Après, nous avons les auteurs. Un auteur se définit comme une personne qui a contribué de manière intellectuelle et significative à l'article.

Il faut qu'il ait une contribution importante, significative de manière intellectuelle pour ce qui concerne la préparation et la conduite de la recherche, l'analyse des données, la présentation des données, la rédaction du document, etc. Toutes ces personnes-là qui vont travailler ensemble pour rédiger l'article vont constituer les auteurs dont on a parlé. Il n'y a pas de nombre magique.

En fonction des travaux, vous allez trouver un auteur, deux, trois auteurs. Vous pouvez trouver dix auteurs ou même plus. En fonction de l'ampleur des travaux, il y a des études multicentriques qui se font sur plusieurs pays avec différentes équipes appliquées.

La liste des auteurs va être plus ou moins longue en fonction de chaque travail. L'ordre des auteurs est très important. Il faut qu'il soit fait en rapport en fonction de la contribution de chacun.

Il faut toujours suivre les recommandations dans ce sens-là. Maintenant, nous passons aux sections de l'article. Nous commençons par l'introduction.

L'introduction est là pour l'objectif de montrer pourquoi le travail a été fait et de montrer l'intérêt du travail. Il doit être adapté à la revue et au public cible, pour essayer de les convaincre de l'intérêt de l'article. En pratique, on peut proposer ces structures de l'introduction.

Dans la première partie de l'introduction, on peut parler de l'aspect général du sujet et on fait une mise au point sur le sujet. On parle de quel sujet on s'intéresse dans cet article et on fait une mise au point sur ce qui est connu concernant ce sujet, quels sont les éventuels problèmes qui nous intéressent. Pour la partie 2, on va parler de l'aspect étudié, c'est-à-dire au sein de ce sujet général, quel est l'aspect particulier qui nous intéresse et c'est quoi le problème par rapport à cet aspect-là.

Enfin, on ramène directement à la troisième partie qui consiste à présenter directement c'est quoi l'objectif du travail. Au niveau de l'introduction, il faut éviter un historique trop long, donc parler de l'aspect général avec l'historique longuement. Il faut éviter de mettre trop de références, mais il

faut aussi éviter de ne pas mettre assez.

Toutes les affirmations qu'on annonce dans notre mise au point quand on parle de l'aspect général du sujet, des problèmes qui existent, il faut qu'ils soient justifiés avec des références et puis il faut utiliser le temps de verbe de manière appropriée. Voici la deuxième partie de cet extrait. Examinez le rôle et le contenu de chaque paragraphe qu'on va discuter lors de la séance interactive.

En ce qui concerne la deuxième section qui est la section matériel et méthode, son but c'est de fournir des détails sur la méthodologie du travail pour que le lecteur puisse comprendre, puisse même reproduire et vérifier le résultat du travail qui a été fait. Il consiste de manière pratique à donner une description complète et ces détails qu'on donne sont très importants pour donner une idée sur la crédibilité du travail qui a été fait et montre la rigueur scientifique des chercheurs. En général, le temps de verbe dans la section matériel et méthode c'est le passé.

Qu'est-ce qu'on va mettre de manière concrète ? On va présenter le type d'études que nous avons faites, le lieu et la période de l'étude, la population cible avec des critères d'inclusion et d'exclusion, l'échantillon que nous avons recruté, on va parler des variables étudiées avec les différentes catégories des variables intégrées et on va parler des méthodes de collecte des données, qu'est-ce que nous avons utilisé comme instrument, qui étaient les enquêteurs, quelles sont les sources de données. Nous devons parler également des méthodes d'analyse des données, donc les méthodes statistiques que nous avons utilisées et les aspects éthiques lorsque nous avons réalisé notre recherche, lorsque nous avons obtenu l'accord du comité d'éthique, lorsque nous avons respecté les principes de l'éthique lorsque nous avons mené notre travail. Tous ces éléments sont importants.

Bien sûr, vous avez vu certains éléments dans le cours de méthodologie de la recherche et tout au long des études, vous allez découvrir les détails concernant les travaux de recherche et les études que vous allez lire dans les différents articles. Quelles sont les erreurs à éviter dans la section matériel et méthode ? Il faut éviter d'introduire des commentaires personnels parce que dans cette section, comme on l'a dit, l'objectif c'est de décrire de manière rigoureuse et fidèle la méthodologie de travail, donc l'auteur doit être le plus objectif possible et éviter les commentaires personnels. Il faut éviter de donner les résultats.

Les résultats vont venir dans la section suivante donc il faut respecter les recommandations et se contenter de parler ici des méthodes. Il faut éviter le style télégraphique. C'est quoi le style télégraphique ? C'est de mettre des idées comme ce que vous voyez sur la diapo, donc de mettre juste des idées comme ça en utilisant les puces.

En fait, dans l'article, de manière générale, dans l'ensemble de l'article, il faut rédiger des paragraphes. Il faut éviter aussi d'introduire des informations qui ne sont pas de la méthodologie de travail mais des informations pertinentes pour la méthodologie de l'étude. De la même façon,

je vous invite à lire ces deux petits paragraphes de l'article, extraits de l'article que nous discutons en exemple pour les voir ensemble lors de la séance interactive.

On arrive maintenant à la troisième section qui est la section résultat. Nous avons décrit pourquoi nous avons fait notre travail. Nous avons présenté les méthodes utilisées.

Maintenant, nous passons au résultat. Le rôle de la section résultat, c'est d'apporter la réponse à la question de recherche. Du coup, l'auteur, là aussi, doit être neutre, doit être objectif.

Le temps des verbes est au passé parce que c'est dans le passé. On va rédiger par exemple nous avons trouvé la proportion de cette maladie qui utilise le passé. Et puis, dans la section résultat, il y a une importante particularité, c'est l'utilisation des illustrations, des tableaux et des figures parce qu'en général, il y a beaucoup de données.

Ces illustrations et ces tableaux nous permettent de résumer de manière très efficace les informations que nous voulons véhiculer au lecteur. Alors, quel va être le contenu de la section résultat ? Donc, une description de la population de l'étude en premier. Donc, on va rapporter le nombre de sujets inclus, leurs caractéristiques sociodémographiques, leurs caractéristiques cliniques et biologiques.

Après, nous passons au résultat principal qui correspond à la réponse à la question de recherche. Par la suite, si c'est prévu dans l'étude, nous allons présenter les résultats secondaires qui répondent à des objectifs secondaires de l'étude. Et enfin, il faut préciser que ces deux types de résultats sont importants et intéressants.

Et la rigueur scientifique veut qu'on présente les résultats quels qu'ils soient. Donc là encore, c'est un extrait de l'article pour la discussion. On va y revenir lors de la séance interactive.

Comme on a dit, les tableaux et figures sont très importants au sein de la section résultats. Il faut privilégier l'utilisation chaque fois que possible. Bien sûr, en respectant les recommandations.

Il faut appeler les tableaux et figures dans le texte. Lorsqu'on lit le texte, il faut trouver la référence du tableau ou de la figure que l'on veut consulter. C'est vraiment dans l'ordre de leur apparition dans le texte.

Ça veut dire qu'on numérote les tableaux ensemble et on numérote les figures ensemble. Il doit avoir des titres, des légendes et des notes. Et on dit que les tableaux et les figures doivent être compréhensibles sans avoir besoin de texte.

Un tableau, avec ses informations qui le concernent, doit permettre de comprendre le message explicatif. Il faut éviter de faire la répétition entre les tableaux, les figures et le texte. Il faut bien sûr suivre les règles standard de format et de contenu.

Vous voyez ici l'exemple d'un tableau. Vous voyez comment on fait les lignes de tableau, les

différentes colonnes, le titre, le numéro du tableau, la légende en bas. Tout ça permet de comprendre l'information véhiculée et que l'intérêt du tableau est de résumer de manière simple des informations compliquées ou très détaillées, très importantes, de les résumer dans un petit espace.

Si on voulait présenter les résultats de ces différentes variables au niveau des lignes du tableau à gauche pour chaque année, ça peut prendre beaucoup de texte et ça va être très compliqué pour le lecteur de suivre. Il va pouvoir organiser en colonnes, il va pouvoir suivre les différentes variables et il va même pouvoir comparer chaque variable en fonction des années et voir l'évolution dans le temps. C'est ça l'intérêt du tableau.

Là on prend l'exemple d'une figure. On trouve la figure avec le titre, le numéro de la figure et on peut voir ce diagramme en secteur pour savoir à quoi il réfère. On arrive maintenant à la quatrième section de l'article, la discussion.

La discussion a pour objectif de résumer les résultats principaux, de comparer les résultats que nous avons observés avec les résultats de la littérature qui sont publiés par d'autres auteurs et de discuter, de juger la qualité et la validité de résultats. Donc, en pratique, on va résumer les principaux résultats qui répondent à la question de recherche, donc qui répondent aux objectifs de l'étude, il faut interpréter ces résultats, c'est-à-dire qu'est-ce que ces résultats veulent dire, il faut vérifier si on a apporté la réponse à la question posée, comparer nos résultats par rapport à d'autres auteurs, expliquer les différences s'ils existent et puis fournir, si besoin, des critiques scientifiques et objectives des travaux des autres auteurs. Il faut faire en sorte à rédiger une discussion qui soit critique et objective des forces et des faiblesses de l'étude.

Donc, on va décrire quels sont les points forts de notre étude et quels sont les points faibles en toute objectivité. En ce qui concerne les forces, on va parler par exemple du type d'étude, de la randomisation si on l'a utilisé, donc des aspects méthodologiques qui font que notre étude est une étude intéressante. Pour ce qui est des faiblesses, il faut surtout discuter les biais, c'est-à-dire le risque des erreurs qui peuvent ou qui risquent de compromettre la validité des résultats.

Donc, il faut savoir que dans toutes les études, il y a des possibilités de biais, il n'y a pas une étude parfaite, donc il faut toujours discuter ces aspects-là de manière, comme on l'a dit, critique et objective. Quelles sont les erreurs à éviter dans la section discussion ? Donc, il faut éviter de discuter l'ensemble du sujet et non le travail lui-même. Ce qui nous intéresse, c'est le travail qui a été fait et les résultats que nous avons trouvés.

Il faut éviter de discuter du sujet de manière générale. Et donc, il faut éviter, c'est le deuxième point, il y a un lien avec le premier, il faut éviter de discuter sous forme de mise au point, c'est-à-dire au article datique. Il ne faut pas venir présenter des aspects théoriques du sujet comme si on voulait enseigner ces notions.

Il faut éviter aussi de déborder sur les objectifs fixés au départ. Donc, on parle de l'objectif, on fait

la méthodologie, on présente les résultats, la discussion doit porter toujours sur l'objectif de l'étude et donc les résultats qui ont été trouvés. Il faut éviter de répéter ce qui a été dit dans l'introduction.

Donc, tous ces éléments au rapport avec le sujet général, les problèmes, pourquoi nous avons fait l'étude, ça c'est dans l'introduction. Il faut éviter de répéter dans la discussion. De toute façon, nous avons dit que les répétitions sont inutiles dans la rédaction et la communication scientifique.

Il faut privilégier la concision. Il faut éviter de faire apparaître une nouvelle donnée concernant le travail. Donc, on va discuter au niveau de la discussion ce que nous avons déjà présenté dans l'article, dans la méthodologie et les résultats.

Il ne faut pas présenter de nouvelles informations, de nouvelles données au niveau de la discussion. Il faut éviter de manquer d'exactitude dans la citation des références. Donc, de manière générale, la précision, l'exactitude, c'est très important.

Donc, quand on cite les références, il faut être rigoureux et éviter les erreurs parce que ça crée la confusion et ça dénote une mauvaise qualité du travail. Il faut éviter de citer à venteur son donné de référence. Donc, par exemple, quand on dit d'après la littérature et les classiques 2, il est important de mettre la référence où est-ce que nous avons trouvé ces informations.

Comme ça, les lecteurs peuvent aller par eux-mêmes et vérifier ces informations-là. Il faut éviter d'utiliser des expressions émotionnelles. Quand, par exemple, on était déçu de, ou il est intéressant de, il faut garder un temps neutre et objectif dans la communication scientifique de manière générale.

Et éviter, bien sûr, une discussion trop longue. En général, on dit qu'il ne faut pas dépasser la moitié de l'article dans la section discussion. Voilà un exemple extrait de l'article qu'on a discuté, qu'on a vu tout au long de cette présentation et qui va être aussi discuté lors de la séance interactive.

Enfin, je termine par les références. Donc, les références, elles ont pour objectif de nous aider à justifier ce que nous énonçons dans notre article. La liste de références doit comporter les références que nous avons citées dans l'article.

Il faut être très précis par rapport aux références que nous avons citées et qui figurent dans la liste des références à la fin de notre article. Une référence peut être un article, un livre, un chapitre de livre, etc. Donc, ça peut être toute ressource utile pour notre travail.

Il faut contrôler les références avec l'article pour éviter les erreurs de transcription. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois vérifier les références que nous incluons et vérifier que nous avons rapporté correctement comme ça. Toujours, c'est dans l'objectif de clarté et de précision.

Comme ça, les lecteurs peuvent aller eux-mêmes chercher cette information et vérifier. Et puis, il faut présenter les références selon le système adopté par la revue. C'est quoi le système adopté par la revue.

C'est comme ce que vous voyez dans cet exemple ici. Donc, ça, c'est un système particulier où on a au début le titre de l'article. Après, on a les auteurs.

Et nous avons à la fin le nom de la revue et l'année de publication. Donc, ça, c'est une manière de présenter les références. Donc, il faut suivre ce qui est demandé par la revue et présenter toutes les références de la même manière.

Bien sûr, les revues ont des recommandations pour les différentes ressources. Donc, il faut juste suivre ces recommandations. Donc, voilà.

C'était la dernière diapo. Je vous donne rendez-vous bientôt pour discuter ensemble vos questions et les aspects pratiques du cours d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce cours qui porte sur le résumé de l'article original.

Donc, le résumé, c'est une partie de l'article qui va rapporter les faits importants pour que le lecteur puisse comprendre l'article. La structure du résumé va suivre la structure de l'article original que nous avons déjà vu, à savoir la structure en red, avec l'introduction qui va décrire pourquoi on a fait cet article, les méthodes qui expliquent comment nous avons réalisé l'étude, les résultats qui rapportent ce que nous avons observé et enfin la discussion qui apporte le sens ou l'interprétation que nous donnons au résultat. De manière générale, le résumé doit être concis, clair et précis.

Dans la partie introduction du résumé, il faut rappeler le contexte de l'étude et lancer son objectif en utilisant une ou deux phrases courtes. Si on prend l'exemple de l'article que l'on a vu lors de la dernière présentation, au niveau du résumé, ils ont lancé directement l'objectif étant d'évaluer l'influence du petit-déjeuner sur la consommation d'aliments sélectionnés et la prévalence du surpoids chez les adolescents de différents groupes d'âge. Au niveau de la section méthode, il faut s'assurer d'inclure le schéma ou l'outil d'étude, la population d'études en précisant les caractéristiques importantes pour son choix avec le type d'échantillons et le nombre de sujets inclus.

Il faut préciser les variables d'intérêt et les méthodes statistiques utilisées. Je vous laisse découvrir la partie méthode de l'article que nous avons pris en exemple et essayer d'identifier les différents éléments qui ont été rapportés par les auteurs. Donc voilà la suite de la partie méthode au niveau du résumé.

En ce qui concerne la partie résultats, il faut résumer les résultats principaux, s'assurer d'avoir inclus le nombre de sujets qu'on a recrutés, il faut mettre des résultats chiffrés donc en fonction de la question de recherche, que ce soit des mesures de risque, des prévalences, des

incidences, etc. Là encore vous avez la partie résultats du résumé de l'article. Je vous invite à examiner cette partie et à vérifier si elle correspond aux recommandations que nous avons présentées.

Cette diapo concerne la deuxième partie de la section résultats du résumé. Quand on arrive à la partie discussion conclusion du résumé, et voici la partie discussion de notre exemple. Enfin, quelles sont les erreurs à éviter dans un résumé ? Il ne faut pas utiliser les abréviations, il faut éviter de rapporter des résultats qui ne sont pas présentés dans le corps de l'article, il faut éviter les phrases longues sans signification, le mauvais emploi du temps des verbes et il faut éviter aussi le commentaire des résultats.

Donc en conclusion, de manière générale, la rédaction scientifique, c'est un exercice important pour le médecin et le scientifique. Elle doit répondre à des exigences de rigueur scientifique. Il y a des recommandations pratiques qui sont disponibles et qui doivent nous permettre avec l'entraînement de maîtriser la méthode de rédaction avec le temps.

Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour la séance interactive. Bonjour et bienvenue dans ce cours qui va porter sur la communication orale. Dans cette première présentation, on va parler de la phase de préparation.

Donc on peut définir la communication orale comme l'action de communication dans laquelle une personne va effectuer l'essentiel de la transmission alors que l'ensemble des autres personnes qui l'écoutent vont effectuer la réception du message. Avant de commencer à travailler sur notre communication orale, il y a des éléments importants à connaître au préalable pour se préparer correctement. Donc déjà connaître le lieu dans lequel nous allons communiquer, les organisateurs, de manière générale l'occasion, le contexte dans lequel se fait la communication, le temps qui nous est alloué parce que c'est très important, c'est un critère très important pour planifier notre communication, quels sont les autres intervenants dans la même séance ou le même événement et quelles sont les caractéristiques de notre audience.

Donc tous ces éléments vont nous permettre de faire des choix par rapport à ce que nous allons présenter et à comment nous allons le présenter. On peut diviser le processus de communication en trois grandes étapes. La première c'est l'étape de la planification, la deuxième c'est l'étape de la préparation à proprement dit du support de communication et enfin la présentation qui se déroule le jour J. Lors de la planification il faut se concentrer sur deux éléments principaux, à savoir l'objectif de la communication, est-ce qu'on a envie d'informer les gens, d'expliquer, de convaincre, d'animer ou de faire agir l'audience.

Donc en fonction de l'objectif on va planifier notre communication et le deuxième aspect c'est l'audience, quel est le nombre de participants ou de personnes qui vont nous écouter, leur composition, leur réaction possible, leur niveau de connaissance du sujet. Ces éléments vont nous permettre aussi de nous préparer pour le développement de notre communication. Donc

pour ma communication orale il faut que je définisse l'objectif de la présentation, donc quelles sont les idées principales de cette présentation, les objectifs précis par rapport au sujet global et l'approche que je vais utiliser.

Je prépare un plan qui va comporter une introduction, une conclusion avec au centre le corps ou le développement de la communication. Donc dans l'introduction on doit chercher à capter l'attention de l'audience et à présenter le sujet de manière claire. Il faut insister sur l'importance, la pertinence et l'intérêt du sujet de cette communication et annoncer les principaux points de la présentation.

Dans le développement de la communication il faut surtout présenter nos résultats et mettre en valeur le travail que nous avons fait. Bien sûr ici je prends l'exemple de présentation qui porte sur des travaux de recherche. En conclusion on annonce la fin de la présentation, on résume les principaux points discutés, on termine avec une idée intéressante pour le public et on présente des perspectives futures en insistant sur les points positifs.

Donc je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans la suite pour parler de la préparation du support de communication et de la présentation orale de manière pratique. Bonjour et bienvenue dans ce cours qui porte sur les supports visuels de la communication orale. Pour préparer les supports visuels de la communication orale il faut savoir qu'il y a des règles à suivre.

Parmi ces règles c'est qu'il faut privilégier les tableaux et les figures parce qu'ils permettent de véhiculer une quantité importante d'informations de manière très simple. Il faut que ces figures et tableaux soient faciles à lire et interpréter par les personnes qui vont écouter notre présentation orale. Il faut avoir un titre pour chaque diapositive ou transparent qu'on utilise pour permettre au public de suivre notre présentation.

Il faut s'assurer que le texte est lisible au niveau de toute la salle. Il faut penser à prévoir une copie papier au cas où il y a un problème technique et qu'on ne puisse pas avoir accès à notre support visuel. Dans les supports visuels nous allons présenter des éléments textuels en premier.

C'est tout ce qui concerne le texte comme la diapo que vous voyez ici. Donc le principe c'est dans chaque diapo il faut présenter une idée et essayer de faire en une minute. Pour cela il ne faut pas inclure beaucoup d'informations et il faut essayer de faire une présentation la plus simple possible de notre idée et éviter bien sûr les phrases longues.

Toujours dans le cadre des éléments textuels, comme on a dit, le principe c'est d'avoir une diapo, une idée, une minute et de proscrire les phrases longues et complexes. Regardez la phrase qui suit. Développez l'idée oralement pendant que l'auditoire lit le résumé sur la diapositive.

Effectivement quand la phrase est trop longue, il est très difficile pour les personnes qui nous

écoutent de suivre. Ils vont être concentrés en train d'essayer de lire le texte plutôt que de suivre notre présentation. Pour ce qui est des choix des polices, il faut avoir une taille de moins 18, éviter d'avoir trop de polices différentes dans la même diapo et tout au long de la présentation.

Essayez de choisir une police qui soit lisible et simple. On peut changer la taille de la police pour montrer les points principaux, les points secondaires par exemple, et éviter d'écrire en capital sauf si absolument nécessaire. Donc comme vous voyez sur cette diapo, c'est relativement difficile de lire quand tout le texte est écrit en capital.

Pour le choix des couleurs, en principe il faut avoir un texte qui contraste avec le fond de la diapo. On peut avoir des couleurs différentes pour certains éléments de style comme les titres, mais il faut essayer de garder une certaine harmonie dans le support de présentation. Les points importants peuvent être en couleurs frappantes comme dans cet exemple, et aussi la même chose pour le texte en graphe.

Il peut être utilisé pour marquer un point important. Donc comme on l'a déjà dit, l'utilisation des graphiques et des tableaux permettent une présentation attrayante des résultats. Il faut donner du temps pour la mise en forme de ces éléments graphiques avec tous les détails, que ce soit en termes d'épaisseur des traits, des couleurs choisies, la taille des polices, etc.

Il faut dédier ce temps pour les préparer du moment qu'ils contiennent une quantité importante d'informations et que vous voulez qu'ils soient efficaces, qu'ils vous aident dans la transmission du message. Vous allez voir dans les exemples dans la séance interactive que des fois il y a des grilles qui sont par défaut dans les graphiques qui n'ont pas d'intérêt, qui vont juste créer une sorte de bruit visuel. Il faut éviter les polices trop petites et surtout il faut avoir pour chaque graphique ou tableau le titre et une légende pour permettre de comprendre leur contenu.

Enfin pour les animations, elles sont intéressantes parce qu'ils permettent d'illustrer certains concepts, ils permettent de montrer un point à la fois et de progresser dans notre présentation. Il faut les utiliser avec parcimonie, avec un nombre réduit de transition au maximum et il faut bien les maîtriser pour ne pas avoir de surprise le jour de notre présentation. Il faut éviter les animations amusantes.

En général dans le contexte de présentation scientifique, on peut avoir quelques animations pour décontracter l'ambiance, mais il faut garder un certain niveau de formalité et de sérieux dans les présentations. Donc je vous remercie pour votre attention et la dernière présentation va porter sur le déroulement de la présentation orale. Bonjour et bienvenue dans cette présentation qui va porter sur le déroulement de la présentation orale.

Donc afin de réussir sa présentation orale, il faut se préparer avant le jour de la présentation. Donc en général on conseille de s'entraîner à faire la présentation comme si on était dans la situation réelle, utiliser le support visuel que nous avons préparé et essayer de respecter le temps alloué comme ça on est sûr qu'on va être dans les temps le jour de la présentation. Bien

sûr, utiliser ces entraînements pour apporter les modifications nécessaires à notre support de présentation.

Et si on a la possibilité de vérifier la salle avant la présentation, c'est très utile, ça nous permet de vérifier la mise en place de la salle, l'équipement, la compatibilité de notre présentation avec l'équipement sur la salle. Cela nous permet de réduire énormément notre stress et d'être bien préparé à la présentation. Le jour de la présentation, il faut pas oublier de penser à aussi il est important en faisant sa présentation d'être conscient de sa posture, de sa voix, ses gestes, c'est-à-dire se concentrer sur comment on se tient, quels sont les gestes, comment est-ce que nous parlons.

Il faut soigner sa prononciation, essayer de contrôler ses mouvements, faire face à l'audience, garder un contact visuel avec l'auditoire, ne pas hésiter à prendre de petites pauses pour bien respirer, pour même boire de l'eau, ça va nous permettre d'être à l'aise au cours de la présentation. Et bien sûr, il faut donner la possibilité à l'audience d'interagir, de poser des questions ou nous pouvons nous-mêmes leur poser des questions pour créer cette interaction. Il est important de s'arrêter sur deux groupes ou catégories d'aspects concernant la présentation, à savoir les aspects verbaux et les aspects non-verbaux.

Dans les aspects verbaux, on va trouver la voix, la tonalité, le rythme avec lequel nous parlons, la prononciation. Dans les aspects non-verbaux, on va trouver la posture, les mouvements, les gestes, les expressions faciales et notre apparence. Donc, ces éléments sont très importants à prendre en considération.

On doit les utiliser tous pour nous aider à réussir notre présentation et à laisser bonne impression auprès de l'auditoire. L'humeur de l'audience est un élément important à essayer de jauger quand on fait notre présentation. Donc, il faut qu'on essaie quand même, même si on est concentré et stressé avec notre présentation, il faut essayer d'être attentif à l'audience, essayer d'observer les réactions, communiquer à un niveau approprié de formalité, avoir un rythme approprié à la présentation et éviter l'arrogance, éviter l'excès d'enthousiasme face à l'auditoire.

Pour ce qui est de la voix, il faut qu'elle soit clairement audible, utiliser un microphone en cas de besoin, lorsqu'il est disponible bien sûr, et essayer de nous mettre dans la situation de cette communication avec un large public, savoir qu'il diffère de la communication en situation ordinaire avec nos amis ou nos collègues, parce que la communication avec un public ou un auditoire, il nécessite une certaine attitude, une certaine posture. Donc, par exemple, il faut garder la tête haute, bien ouvrir la bouche, parler lentement, bien articuler et essayer de contrôler la tonalité. Tout ça doit servir à transmettre au maximum notre message.

Pour ce qui est du langage corporel, il faut avoir une bonne posture, bien se tenir debout, éviter de trop bouger, utiliser les mains de manière appropriée, avoir un contact visuel avec l'audience, essayer d'éviter l'éthique, éviter les mains dans les poches. Pour les supports visuels dont on a

parlé lors de la dernière présentation, il faut bien sûr s'assurer que notre support visuel est bien lisible, que ce soit des diapos, par exemple, en cas d'utilisation d'un tableau qu'on est en train d'écrire au fur et à mesure. Il faut s'assurer que les gens voient ce qu'on est en train d'écrire, donc il faut essayer de se mettre sur le côté et leur laisser la possibilité de voir.

Il ne faut pas entraver la vue de l'écran ou du tableau. Il faut utiliser, quand c'est pertinent ou c'est utile, un dispositif de pointage pour montrer les points sur lesquels on veut insister et ne pas se mettre face à l'écran quand on parle et du coup ne pas tourner le dos à l'auditoire. Pour ce qui est du temps de la présentation, il faut toujours respecter le temps alloué.

C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut s'entraîner à l'avance pour s'assurer que la présentation qu'on prévoit de faire correspond bien au temps qui nous a été alloué et aussi bien répartir le temps sur les différentes parties de notre présentation. Enfin, pour conclure notre présentation, il faut essayer de terminer sur le même enthousiasme que le début, essayer d'impliquer l'audience et bien sûr d'annoncer la fin de la présentation. Après la présentation, il faut avoir une opportunité pour écouter les questions de l'auditoire et répondre à leurs questions.

Il est très utile d'anticiper les questions de l'audience et préparer les réponses, mais de manière générale, au moment de la séance ou la session de questions, il faut écouter attentivement, essayer de s'assurer qu'on a bien compris la question avant de formuler sa réponse et même demander à la personne de répéter la question ou répéter nous-mêmes la question pour s'assurer que nous avons bien compris, parce que le fait de bien comprendre la question est très critique pour donner une réponse qui soit pertinente et attendue par la personne qui a posé la question. Toujours dans le cadre de la réponse aux questions, donc il faut privilégier les réponses brèves, ce n'est pas le moment de reprendre la communication orale qu'on a faite, il faut être humble et honnête et ne pas hésiter à dire que je ne sais pas ou que je n'ai pas la réponse à cette question. Il faut contrôler l'échange, c'est-à-dire ne pas permettre qu'une personne monopolise la parole et que toute la discussion soit concentrée sur cette personne.

Pour terminer, nous insistons sur les problèmes à éviter, donc au niveau du support visuel, surtout éviter les problèmes des couleurs, la longueur du texte, les fautes d'orthographe, les répétitions inutiles et l'excès d'animation. Et pour le comportement de l'orateur, il faut éviter le temps monotone, éviter de lire les diapositives, de tourner le dos à l'auditoire, éviter d'aller trop vite ou trop lentement, c'est par rapport au rythme de notre présentation. Donc merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous lors de la séance interactive pour discuter des aspects pratiques de ces éléments.

Chers étudiants, j'ai le plaisir de vous enseigner les cours de la communication professionnelle faisant partie du module des techniques de communication. Je suis Imena Adeli, professeure de psychiatrie. La deuxième partie du module concernant la communication scientifique vous sera enseignée par le professeur Adr Mouch.

Le cours d'aujourd'hui est intitulé « Les bases théoriques de la communication ». A la fin de ce cours, vous serez capables de connaître les définitions de la communication, citer les différents types de communication et leurs outils, connaître les différentes situations de communication, connaître les caractéristiques de la communication interne, connaître les enjeux de la communication et enfin analyser les dysfonctionnements dans la communication. La communication est une activité humaine fondamentale. On ne peut pas ne pas communiquer.

Elle est définie comme étant un ensemble de processus par lesquels s'effectuent les échanges d'informations et de significations entre des personnes dans une situation sociale donnée. La psychologie sociale définit la communication comme le fondement des phénomènes qui régissent l'élaboration et la pérennité des relations sociales et de leurs produits, comme les attitudes, les représentations, les idéologies et autres. Une action de communication peut être définie en répondant aux questions suivantes.

Qui dit quoi, quoi, par quel canal, à qui et avec quel effet? Il faut noter l'aspect pluridimensionnel, cognitif, émotionnel, comportemental de la communication. Les mots communiquer et communication apparaissent dans la langue française signifiant partage à deux ou à plusieurs. Le mot communiquer commence aussi à signifier transmettre.

C'est alors que les transports, les téléphones et les médias deviennent des moyens de communication. En 1949, une formule mathématique a été appliquée à la communication par télégraphe. Cette théorie admet un schéma de base où la communication consiste en la transmission par un émetteur d'un signal à un récepteur, transmettant en son tour le signal reçu sous forme de messages ind Destinataires.

Moins de 30 ans plus tard, la notion de communication se retrouve définie de plus de 100 façons différentes et étudiée dans une vingtaine de disciplines, y compris les études médicales. Maintenant, on va aborder le chapitre communication professionnelle. Il existe plusieurs types de communication professionnelle.

D'abord la communication orale. En personne, elle est plus riche, s'ajuste facilement aux réactions de l'interlocuteur. Au téléphone, elle est moins riche car l'information visuelle est perdue.

On va voir dans les chapitres suivants que le contact visuel est un élément très important de la communication. Le deuxième type de communication est la communication écrite. Par rapport à la communication orale, la quantité d'informations partagées est plus restreinte.

Par exemple, la rédaction d'une demande de consultation ou d'un examen paraclinique, la rédaction d'un rapport médical ou autre. Le troisième outil est l'utilisation de supports visuels et audiovisuels. La communication par vidéo est riche dans la mesure où elle permet de retrouver l'image, c'est-à-dire le non verbal, et la conversation en direct.

Par exemple, la télémedecine. Je vous demande de faire une recherche concernant la signification du terme télémedecine. On va discuter ça lors des séances interactives.

En ce qui concerne les présentations, elles sont plus efficaces de par la rétention et la compréhension de l'information par les participants. Par exemple, les séances d'éducation thérapeutique. Il existe deux situations de communication.

La communication interpersonnelle mettant en relation deux personnes. Exemple, entretien avec un malade ou entretien avec un parent d'un malade. La communication dans un groupe met en relation plusieurs personnes.

Exemple, les groupes de psychoéducation ou la communication au sein d'une équipe de garde. Maintenant, on va passer aux formes de la communication. Concernant les formes de la communication, on va traiter d'abord la communication interne.

Elle a pour objectif de mettre en relation des individus afin de faciliter leur action collective. Il existe deux types de rapports entre les communicants. Ce qu'on appelle un rapport asymétrique qui induit la distance dans la relation.

En effet, l'information est partagée de la façon suivante. Une information descendante d'un supérieur qui donne des consignes à un subordonné et une information ascendante d'un subordonné qui rencontre un supérieur hiérarchique. Le deuxième type de rapport entre les communicants est le rapport symétrique qui induit de la proximité dans la relation.

C'est une relation d'égalité et de coopération sur un projet commun. Le degré de convergence ou de divergence entre les personnes peut se voir au niveau des opinions, on peut être en accord ou en désaccord, au niveau des intérêts qui peuvent être partagés ou incompatibles, au niveau des affinités, attirance versus répulsion et au niveau du rapport des positions, par exemple chef-subordonné. Ce schéma explique le rapport asymétrique dans la communication interne.

Lors de la communication descendante, l'émetteur en position de supérieur donnera des ordres, des informations, des conseils écrits ou oraux sous forme de notes de service, d'informations, de consignes et autres. Dans la communication ascendante, l'émetteur en position de subordonné informera de son travail en donnant des comptes rendus, une synthèse ou des rapports. En plus de la communication interne, il y a la communication externe qui concerne les actions sociales, les médias et autres.

Plusieurs modèles ont été élaborés pour expliquer le processus de la communication. Selon le modèle linéaire de transmission de l'information, la transmission de l'information serait assurée par une chaîne de plusieurs éléments. Une source d'information, un émetteur qui transforme le signal en un code, un canal de transmission, un récepteur qui décode les signaux, une rétroaction ou un feedback qui permet le maintien ou perturbe l'équilibre de la communication.

Pour illustrer ce modèle, on va prendre l'exemple d'un médecin qui informe son patient sur les symptômes du diabète. Je vous demande de préciser les éléments de ce modèle à partir de l'exemple. On va traiter ça lors des séances interactives.

Les théories et modèles de l'école de Palo Alto ont mis en évidence la complexité du processus de communication. D'abord, il faut décoder les contenus implicites. La relation entre les personnes influence en permanence le contenu du message.

Et enfin, la communication est un processus dynamique et non pas figé dans le temps. Le modèle associant partage du sens et contexte met l'accent sur le rôle prépondérant du récepteur dans l'interprétation des signes verbaux et non-verbaux. Exemple, les signes d'impatience et les signes d'encouragement sur les enjeux que chacun projette dans la relation qu'il établit avec les autres.

Exemple, donner une image valorisée de soi-même aux autres. Et enfin, ce modèle a mis l'accent sur les codes, valeurs, normes, différences socio-culturelles qui influencent la communication. La communication, justement, varie en fonction des statuts des acteurs, des lieux, du temps disponible et autres.

Le premier enjeu de la communication est de se faire comprendre, émettre et recevoir des signaux auxquels nous accordons tous la même signification. En effet, tout est porteur de sens, les vêtements, le regard, l'attitude, l'expression, le sourire, le lieu et autres. Exemple, de par la tenue, le comportement, on montre à la société qu'on connaît les règles de la courtoisie.

Les relations échangées au sein d'une société obéissent à des codes et à des rites. Ceux-ci sont liés au besoin de proposer une image de soi conforme aux normes de la société en vigueur. Leur transgression peut être vécue comme un signe d'une agression.

Exemple, respect à l'égard d'un supérieur hiérarchique, fumer dans un espace non fumeur, on communique aux autres qu'on respecte les normes de la société. On décrit plusieurs sites de distance interpersonnelle, intimité, distance sociale, distance publique ou autres. La distance interpersonnelle diffère selon les cultures.

On va détailler cette partie dans les chapitres ultérieurs. Les enjeux de la communication sont l'enjeu informatif qui consiste à communiquer une ou des informations, l'enjeu d'expression de son identité par le besoin d'intégration au sein d'un groupe, de valorisation personnelle, de reconnaissance sociale. Par l'enjeu de pouvoir, on assure son autorité sur une personne, son leadership sur les membres d'une équipe ou d'un groupe.

Dans l'enjeu d'influence, celui qui s'exprime a des idées qu'il souhaite voir adoptées par les autres. Et dans l'enjeu de séduction, l'intervenant souhaite se faire apprécier, aimé par les autres, par le biais de la séduction. Pour le chapitre enjeux de la communication, veuillez préparer, lors de la prochaine séance interactive, des exemples qui illustrent chaque enjeu.

On avait parlé lors de l'introduction de la complexité du processus de communication. Maintenant, on va détailler comment. D'abord, il faut prendre en compte le contexte de réception.

Au niveau du contenu, il faut sélectionner les informations les plus pertinentes à transmettre, soigner son expression écrite, respecter l'orthographe et autres. Il faut utiliser un code connu du récepteur. En effet, le système de référence du récepteur, c'est-à-dire l'ensemble de ses valeurs, de ses connaissances, son éducation, sa culture, sa langue, doit être respecté.

Les dysfonctionnements dans la communication proviennent du manque de temps, de la difficulté du responsable hiérarchique à communiquer et le poids de la hiérarchie, qui entraîne une faiblesse de la communication ascendante, la centralisation excessive et la retenue de l'information, les rivalités entre les personnes, la mauvaise connaissance de « qui fait quoi » et les rumeurs et discordances. Même s'il est illusoire de penser que la communication puisse être parfaite, s'interroger sur sa complexité, sur l'ambiguïté des messages, les interprétations possibles de la part du récepteur, les enjeux souvent cachés, contribuent à améliorer sa qualité. Je vous remercie pour votre attention.

Chers étudiants, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce cours concernant la communication interpersonnelle dans le cadre de la relation soignant-soigné. Les objectifs de ce cours sont définir la communication interpersonnelle, définir les objectifs de la communication interpersonnelle, décrire les techniques de la communication interpersonnelle et connaître les éléments de la communication non violente. Est-ce qu'il y a un intérêt à enseigner les techniques de communication lors des études médicales ? En effet, les habiletés relationnelles et de communication sont devenues une compétence clinique essentielle pour tout médecin.

La communication est l'outil principal de travail du médecin permettant la collecte, la transmission de l'information ainsi que la prévention, l'éducation et la promotion de la santé. La littérature a montré qu'une communication efficace améliore globalement l'état de santé du patient, augmente la satisfaction et surtout diminue le nombre de plaintes contre les médecins, améliore la collecte des données lors de l'anamnèse, augmente l'observance du traitement et améliore les résultats cliniques en motivant les malades à prendre leur traitement, surtout lors des pathologies chroniques comme le diabète. Enfin, elle conditionne la qualité du travail et la prévention des risques.

Dans cette diapositive, vous trouverez un exemple illustrant l'importance de la communication dans le domaine de la santé, dont l'introduction récente de cours de formation à la communication professionnelle dans les cursus médicaux. Lors de la rencontre avec le patient, le médecin fait mobiliser ses capacités de communication et d'écoute en plus de ses compétences et connaissances cliniques. Il doit adapter ses interventions selon la capacité de comprendre les informations.

Le médecin joue plusieurs rôles auprès des patients, soignants, éducateurs et autres. Les

objectifs de la communication interpersonnelle sont établir une relation thérapeutique qui est nécessaire pour obtenir la confiance du patient et le soutenir, la transmission d'informations, qu'il s'agisse soit de l'annonce de la maladie ou de son évolution, de la nécessité d'un traitement et ou de ses effets secondaires, ou encore de structurer une relation. Concernant la prise de décision, les patients ont le droit d'être informés et de participer activement à la prise de décision concernant les traitements.

Cela est au cœur même de l'approche centrée sur le patient qu'on va étudier ultérieurement. Dans les stratégies de la communication interpersonnelle, on décrit la communication verbale, la communication non verbale et la communication paraverbale. Les éléments de la communication non verbale sont d'abord le contact visuel qui est à privilégier pour souligner une information importante lors de l'écoute et lorsque le médecin désire donner la parole à son patient.

Il est chargé d'émotion, il est donc important de ne pas fixer des yeux longtemps afin d'éviter de gêner son interlocuteur ou de créer des perceptions erronées. Les malades ont tendance à lire dans le regard du médecin, surtout lors de l'annonce d'une mauvaise nouvelle. L'évitement du regard visuel est une cause d'échec lors de la communication.

L'expression faciale ou mimique est recherchée par les patients afin d'anticiper le diagnostic. L'intérêt est de garder une attitude neutre. Le sourire est un moyen d'entrer en contact avec le malade.

Il doit être adapté à la situation. Les missions de signes d'attention et d'inclinaison lors de la tête sont des renforceurs positifs de la communication. Les postures les mieux adaptées sont les postures dites ouvertes, c'est-à-dire orientation du visage et du corps vers le patient, une inclinaison discrète du buste en avant et une ouverture posturale, c'est-à-dire des membres symétriques non croisés.

Quant à la distance interpersonnelle, elle varie en fonction des cultures. Elle est optimale quand on est à l'aise avec son interlocuteur. On passe maintenant à la communication paraverbale qui concerne les caractéristiques de la voix.

D'abord le timbre de la voix. Un timbre grave induit une perception de calme et de sérénité par rapport à un timbre de voix plus aiguë. Il faut moduler les timbres de voix graves et aigus en fonction du contexte.

Le changement d'intonation entraîne une meilleure attention et améliore la compréhension du patient. Débit verbal et articulation sont souvent liés. Si l'articulation est précise, les mots sont plus distincts et le débit verbal est plus adapté.

Le débit verbal est souvent influencé par les émotions. Ainsi, le médecin se doit de garder un affect le plus neutre possible. Le volume sonore doit toujours être adapté à la situation.

Dans la société occidentale, quelqu'un qui s'exprime avec un faible volume sonore sera jugé comme peu sûr de lui. La pause correspond à un temps de silence, de non-parole. Respecter ce silence est nécessaire.

La pause permet de mettre de l'ordre dans ses idées et de libérer ses émotions. Il s'agit d'un élément facilitateur de la compréhension et de la mémorisation. Vous avez remarqué que j'ai fait un temps de pause long.

En fait, c'est un temps de pause qui est mal utilisé. Il peut générer de l'angoisse, induire l'impression de perdre son temps et engendrer de l'impatience. Probablement, beaucoup d'entre vous sont déjà passés à la diapositive d'après.

On passe maintenant à la communication verbale. La première technique est l'écoute active. C'est une façon d'écouter où le récepteur montre son attention par le biais de techniques verbales et non-verbales appropriées.

Les outils de l'écoute active sont les questions de clarification, la reformulation, le résumé des sentiments, le résumé, le feedback et la réflexion. On va détailler d'abord les questions de clarification. En fait, on les pose pour obtenir des renseignements complémentaires.

La reformulation est utilisée pour s'assurer que nous pensons et interprétons de la même manière que l'autre personne. Elle sert à montrer que l'on écoute et comprend ce qu'on nous dit. Troisième technique de l'écoute active est le résumé des sentiments.

Il consiste à récapituler et à éclaircir ce que l'autre dit dans le domaine émotionnel. Quant au résumé ou récapitulation, il est utilisé pour résumer la discussion. Il peut servir de base pour une discussion ultérieure.

Le feedback est une information au retour, permettant à l'émetteur de savoir si son message a été reçu et comment il a été reçu ou compris. La réflexion est utilisée pour montrer qu'on comprend ce que l'autre personne ressent au sujet de ce qu'il dit. On l'utilise pour l'aider à évaluer et à modérer ses propres sentiments.

Il faut mettre en mots les émotions de l'autre personne. Comment améliorer l'écoute? Prendre le temps de bien enregistrer et penser à ce qui est dit. Se faire des résumés intérieurs de ce que nous entendons.

Identifier les points saillants du discours. Éviter d'être distrait ou accaparé par des sentiments qui nuisent ou bloquent notre attention. Savoir se concentrer en dépit des distracteurs pouvant venir de l'environnement.

Voir au-delà de l'apparence physique du langage ou des manières de notre interlocuteur. Deuxième technique de la communication verbale et les questions réponses. Les principales

formes de questions sont les questions ouvertes qui permettent la libre expression.

Elles sont non directives. Les questions fermées concernent un fait précis. L'empathie est la capacité à imaginer une situation du point de vue de son interlocuteur, à ressentir ce que l'autre éprouve et à comprendre ses attitudes.

Je vous demande d'illustrer les questions ouvertes et questions fermées par des exemples pour la prochaine séance interactive. La technique de motivation vise à susciter chez le patient un changement ou continuer un comportement. On va la voir en détail lors de l'entretien motivationnel.

Qu'est-ce qu'une communication non violente ? Elle est définie par la capacité à développer de nouveaux comportements plus adaptés à une nouvelle situation. Être en mesure d'exprimer sa propre personnalité sans susciter l'hostilité de son environnement ou oser s'abîmer tout en gardant des relations positives avec son environnement. La communication non violente se déroule en quatre étapes.

D'abord l'observation des faits. Observer dans le calme ce qui est dit les paroles ou les gestes d'autrui nous rendent mal à l'aise ou à l'aise. Deuxièmement l'expression des sentiments, des sensations et des émotions.

S'interroger sur ce qu'on ressent triste, joyeux, inquiet, amusé, fâché par rapport aux faits décrits. Identifier et exprimer ses besoins à l'origine de notre sentiment. A la fin exprimer une demande claire, dire à l'autre ce qu'on désire pour que notre vie soit plus agréable.

Il faut éviter d'utiliser le sarcasme ou les sous-entendus. Il faut être clair et aller droit au but. Je vous demande de penser à un exemple illustrant la communication non violente avec ces quatre étapes.

Pour résumer, les principes de la communication sont la disponibilité, être en situation d'écoute active du patient et décoder les éléments de la communication verbale et non verbale, adapter son comportement, sa démarche à la situation du patient, donner des explications claires concises, contrôler la compréhension, obtenir le consentement éclairé du patient, respecter les silences, adaptation de la forme et du contenu du discours à son interlocuteur, utiliser des questions ouvertes et fermées en fonction du contexte et reformuler si nécessaire. Cette diapositive illustre l'importance des techniques non verbales et paraverbales dans le domaine de la communication. En effet, les études ont montré que le message passe par le langage verbal dans uniquement 7% des cas, le timbre de voix dans 20 ou 22% des cas, les comportements dans 55% des cas, c'est-à-dire contact visuel, posture, expression faciale, distance interpersonnelle.

Ces messages sont soit positifs, soit négatifs, ils sont rarement neutres. La connaissance de tous ces facteurs permet d'améliorer la qualité de la communication et la relation médecin-malade. En

conclusion, il n'y a pas une communication mais des communications, car il y a différents types de stratégies, différents types de patients, différents médecins et différentes pathologies.

Les bonnes pratiques de communication entraînent à court et à long terme un meilleur ajustement psychologique face à la maladie et permettent l'alliance thérapeutique. Je vous remercie et à très bientôt. Chers étudiants, j'ai le plaisir de vous rencontrer encore une fois pour traiter ce cours sur l'approche clinique centrée sur le patient.

Les objectifs de ce cours sont comparer l'approche centrée sur le patient au modèle traditionnel des soins, écrire les principes de l'approche centrée sur le patient et savoir utiliser les outils de l'approche centrée sur le patient. L'approche clinique centrée sur le patient s'appuie sur une relation de partenariat avec le patient, ses proches et le professionnel de la santé, visant à bien se représenter les problèmes de santé et comprendre le vécu du patient au regard de ses problèmes. Cette approche s'appuie sur la relation symétrique de communication qu'on a vu dans les chapitres précédents et qui est basée sur le principe de la coopération.

Il faut intégrer cette approche dans l'ensemble de la démarche de soins, du recueil des données jusqu'au suivi thérapeutique. L'approche centrée sur le patient comporte six composantes complémentaires et interreliées. Explorer la maladie et l'expérience de la maladie vécue par le patient.

Comprendre la personne dans sa globalité bio-psycho-sociale, c'est-à-dire la maladie et ses symptômes, le vécu psychologique et social. S'entendre avec le patient sur le problème, les solutions et le partage des responsabilités entre le médecin et son malade. Valoriser la prévention, la promotion de la santé, développer la relation patient-médecin et faire preuve de réalisme.

Actuellement, toutes les études s'accordent sur l'importance de l'approche centrée sur le patient. Alors, est-ce qu'il y avait un modèle traditionnel et quels sont ses caractéristiques? En effet, dans le modèle traditionnel de soins, le rôle du patient est passif. Il écoute le professionnel de la santé expliquer le traitement.

La prise de décision est essentiellement assurée par le professionnel de la santé qui n'offre pas d'options. Il s'agit d'un modèle centré sur la maladie et sur les symptômes. Concernant la communication, c'est surtout le professionnel de la santé qui parle, n'accorde que très peu de temps au patient pour poser les questions.

Le plan de traitement est recommandé et fourni au patient. Ce plan est axé sur le traitement de la maladie diagnostiquée. Quels sont les reproches qu'on a sur ce modèle traditionnel? En effet, au cours de ces dernières décennies, ce modèle paternaliste a fait l'objet de critiques tant de la part des professionnels de la santé que de la part des patients.

Les professionnels sont d'avis que ce modèle traditionnel n'est pas efficace puisque les patients

ne suivent pas nécessairement les consignes du médecin, surtout dans les cas de la prévention ou dans le traitement des maladies chroniques tels le diabète. Quels sont les principes directeurs de l'approche centrée sur le patient? Explorer la maladie et l'expérience de la maladie. Demander l'avis du patient.

A pour attente, c'est l'agenda caché du patient. V pour vécu, émotion, représentation. I pour impact et S pour symptôme.

Concernant les attentes du patient, il faut les clarifier par rapport au rôle du médecin, soignant, assurant la prévention, l'éducation, le suivi ou autre. Par rapport aussi aux investigations, par rapport au traitement, ses modalités curatives ou palliatives, ses effets secondaires et autres. Il faut aussi explorer le vécu du patient au niveau émotionnel par rapport à sa maladie.

Il faut explorer ses idées, ses représentations de la maladie. Par exemple, le cancer est synonyme de mort chez beaucoup de malades. La maladie mentale est synonyme de folie.

Il faut explorer aussi son vécu dans l'entourage. Est-ce qu'il s'agit d'un entourage soutenant ou plutôt déstabilisant? On explore l'impact de la maladie au niveau socio-professionnel. Est-ce qu'elle est cause d'absentéisme fréquent? Et les répercussions du problème sur la vie quotidienne, c'est-à-dire on explore l'handicap causé par la maladie.

Chez certains patients épileptiques, certains sports sont contre-indiqués. On n'aborde les symptômes vraiment qu'à la fin en termes de localisation, qualité, horaire, facteur soulagement aggravant et autres. Il s'agit d'un schéma qui résume les principes de l'approche centrée sur le patient.

On va aborder maintenant le chapitre sur les stratégies de mise en œuvre de l'approche centrée sur le patient. D'abord écouter, partager des informations. Qu'en informer? Aussi souvent que nécessaire, il faut bien choisir le moment adéquat, vérifier si le patient désire entendre les nouvelles ou s'il souhaite attendre.

Selon quelle modalité, l'information doit être personnalisée, hiérarchisée, compréhensible par le patient. Elle doit être cohérente, située dans la démarche des soins. Vérifier, c'est-à-dire reformuler par le patient de ce qu'il a compris et comment participer au soin.

Ensuite, la prise de décision doit être partagée entre le patient et le médecin, qui présente les différents choix thérapeutiques possibles avec accord mutuel sur une option de soin. S'accorder sur l'adoption d'objectifs cliniques, biologiques, psychosociaux de changement et d'habitude de vie. S'accorder sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et aux modalités de suivi et de soutien.

Troisièmement, écouter et soutenir le patient tout au long de son parcours. Reconnaître les efforts du patient ou de ses proches et encourager les comportements bénéfiques à la santé et

les soutenir. Soutenir la motivation du patient à se soigner et faciliter l'expression du patient sur ses difficultés, les analyser, les comprendre et rechercher les solutions avec le patient ou ses proches.

Il s'agit d'un tableau important qui compare le modèle de soin traditionnel par rapport à l'approche centrée sur le patient. Vous voyez que la priorité du médecin dans le modèle de soin traditionnel est la maladie. Tandis que dans le modèle de soin centré sur le patient, la priorité du médecin devrait être le patient.

En conclusion, dans l'approche clinique centrée sur le patient, les patients participent beaucoup plus activement aux décisions concernant leur traitement. Ils sont beaucoup plus susceptibles d'exprimer leurs besoins et leurs opinions. Le rôle important du patient à mener à une relation plus équilibrée entre le médecin et le patient, c'est le type de relations symétriques.

Je vous remercie. Chers étudiants, j'ai le plaisir de commencer avec vous une série de situations de communication clinique spécifiques. D'abord la première concerne l'entretien motivationnel.

Les objectifs du cours sont citer les applications de l'entretien motivationnel dans la relation de soin, citer les principes de l'entretien motivationnel, décrire les étapes de l'entretien motivationnel et savoir utiliser les outils de l'entretien motivationnel. L'entretien motivationnel est une méthode de communication directive centrée sur la personne et visant au changement de comportement par l'exploration et la résolution de l'ambivalence qu'on va voir après. Il est développé au départ dans le cadre des dépendances.

Son utilisation a ensuite été étendue à tout changement de comportement dans le cadre de la santé, y compris dans les maladies chroniques. En effet, l'entretien motivationnel est indiqué lorsqu'il est question d'un changement de comportement, lorsqu'une personne est ambivalente à l'égard d'un changement, c'est-à-dire que cette personne là veut changer mais elle ne peut pas, lorsqu'on veut faire baisser la résistance au changement chez les patients totalement inconscients de leurs problèmes. L'entretien motivationnel aide la personne à prendre la décision de changer ses habitudes qui influencent négativement son état de santé.

L'entretien motivationnel est démontré efficace dans les changements des habitudes de vie. Exemple, abus d'alcool lors de l'activité physique et perte de poids, la cessation tabagique pour assurer l'observance médicamenteuse et dans la prise en charge du diabète. Quelle est la différence entre motivation et volonté ? La motivation est l'ensemble des motifs expliquant une action.

Quant à la volonté, elle correspond à l'énergie et aux moyens pour réaliser la décision. Enfin, la décision est la conséquence de la motivation, c'est l'engagement vers un nouveau comportement. D'où vient l'absence de motivation ? La plupart des patients ne sont pas nécessairement prêts à changer.

Ils sont généralement ambivalents face à un changement. L'ambivalence est le dilemme devant chaque changement. Exemple, je veux perdre du poids mais je ne peux pas me passer des sucreries.

C'est un phénomène normal et prévisible et non l'expression d'une pathologie. Un intervenant de santé qui tente de résoudre le dilemme en favorisant une option risque d'induire le report du sujet vers l'autre option. Donc il ne faut pas prendre parti.

Les principes de l'entretien motivationnel sont la collaboration qui veut dire que le patient est considéré comme expert de sa maladie, car il en a l'expérience. Le soignant est considéré comme étant l'expert pair de la santé et de la prise en charge de la maladie. L'idée est que la consultation est un échange entre les deux expertises.

Le respect de l'autonomie veut dire qu'il faut pouvoir accepter que le patient prendra lui-même ses décisions, surtout celles qui concernent le traitement. L'empathie, qu'on a déjà vu, est la clé de toute relation thérapeutique efficace. Ce schéma montre que l'ambivalence fonctionne comme une pendule.

Cela amène le patient ou la personne à des actions contradictoires. Comment pratiquer un entretien motivationnel? D'abord la création de l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique est un niveau plus élaboré de la relation thérapeutique où le patient et le médecin deviennent des alliés.

Comment on crée l'alliance avec le patient? En respectant son autonomie. Il n'y a que vous qui puissiez décider de modifier vos habitudes alimentaires par exemple. En étant empathique et sans juger.

Pour pratiquer un bon entretien motivationnel, il faut se focaliser sur un seul sujet en élaborant l'agenda de l'entretien et en restant focalisé pendant tout l'entretien. La troisième étape, c'est susciter le discours changement, c'est-à-dire partir des objectifs de la personne pour favoriser le discours changement. Il s'agit là de l'étape la plus pertinente.

A la fin, il faut construire de manière collaborative un plan de changement. Les outils utilisés lors de l'entretien motivationnel sont les questions ouvertes, le reflet ou réflexion, le résumé et la valorisation. Les questions ouvertes commencent toujours par comment, pourquoi, qu'elles seraient.

Ils permettent au patient de s'exprimer, de développer ses idées et surtout d'élaborer, contrairement aux questions fermées. Dans l'écoute réflexive ou réflexion, on s'appuie sur le discours du patient et on lui reflète ses propos avec les mêmes ou avec d'autres mots afin de bénéficier d'une sorte d'écho, de miroir. Cela permet au patient de prendre du recul et reflète l'énoncé de ses motivations ou des pistes de changement.

Le renforcement a pour objectif la valorisation des démarches du patient. Il faut le soutenir et l'encourager dans le changement. Les conséquences du renforcement sont l'augmentation de la confiance de soi, la diminution de la discorde ou de la résistance qu'il peut y avoir dans l'entretien avec le soignant, surtout au début.

Enfin le résumé est un outil important dans l'entretien motivationnel. Lors de l'entretien motivationnel, l'information n'est pas fournie n'importe comment mais de manière collaborative. L'information ou le conseil n'est pas donnée d'emblée afin qu'il ne soit pas considéré comme intrusif et que la personne y porte de l'intérêt.

Il faut évaluer d'abord ce que connaît le patient, proposer ensuite un complément d'information et terminer en demandant un feedback sur l'information donnée. Comme vous pouvez le constater, on a déjà étudié toutes ces techniques dans le cours de la communication interpersonnelle. En conclusion, l'entretien motivationnel se trouve au cœur de la relation éducative ou éducation thérapeutique qu'on va aborder dans le prochain chapitre.

Je vous remercie. Chers étudiants, j'ai le plaisir de vous retrouver pour continuer notre série de situations de communication clinique spécifique entrant dans le cadre des techniques de communication. Aujourd'hui, on va voir la situation de l'éducation thérapeutique.

Les objectifs du cours sont définir l'éducation thérapeutique, citer les domaines d'intervention de l'éducation thérapeutique, décrire les étapes de la démarche de l'éducation thérapeutique et planifier une séance d'éducation thérapeutique. Tu me dis et j'oublie, tu m'apprends et je me souviens, tu m'impliques et j'apprends et c'est ce qui est important. Selon l'ONS, l'éducation thérapeutique du patient est un processus continu intégré dans la démarche de soins et il est centré sur le patient.

Rappelez-vous de l'approche centrée sur le patient qu'on a vu dans les chapitres précédents. Il comprend des activités organisées, il est surtout structuré. Ces activités concernent la sensibilisation, l'information, l'apprentissage, l'accompagnement psychosocial et le traitement et les soins.

L'éducation thérapeutique du patient a avant tout pour objectif de développer les capacités du patient à prendre en charge sa maladie, c'est-à-dire rendre le patient autonome face à sa maladie. L'OMS précise que ce processus vise à aider le patient et son entourage à comprendre la maladie et le traitement, à mieux coopérer avec les soignants et à maintenir ou améliorer sa qualité de vie. Éduquer ou enseigner, quelle différence ? L'éducation thérapeutique du patient est un processus qui ne peut pas se résumer en la délivrance d'une information, même si cette information est de qualité.

Selon l'OMS, l'éducation est l'action mais surtout le processus facilitant la formation et le développement d'aptitudes et de caractéristiques physiques, intellectuelles, motrices,

sensorielles et affectives d'une personne. Éduquer ne peut donc pas se résumer en la transmission de savoir ou de savoir-faire. Cet ensemble de connaissances doit être transformé en savoir-être, conduisant à l'acquisition de compétences d'auto-soins et de compétences psychosociales.

Par exemple, éduquer un patient diabétique ne se résume pas en lui expliquant les symptômes de la maladie ou les différentes modalités de traitement ou les choix thérapeutiques, non. Éduquer un malade diabétique concerne avant tout un savoir-être et comment vivre avec sa maladie. Il existe plusieurs modèles de santé.

D'abord le modèle biomédical de santé qui se centre sur la maladie et l'organe en souffrance, sans prendre compte de l'ensemble des facteurs sociaux, environnementaux et personnels qui interagissent dans la maladie. Par exemple, dans l'obésité, l'approche uniquement centrée sur la diététique apporte un savoir et un savoir-faire, mais pas un savoir-être. Quant au modèle biopsychosocial, il s'intéresse à l'ensemble des facteurs qui interagissent dans l'évolution de la maladie chronique.

Il est plus centré sur le patient que sur la maladie. Quels sont les domaines d'intervention de l'éducation thérapeutique ? D'abord, toutes les pathologies chroniques, diabète, asthme, insuffisance rénale, lombalgie, angore et infarctus, pathologie psychiatrique comme la schizophrénie, la maladie d'Alzheimer et autres. Et ce, quel que soit le type, le stade et l'évolution de la maladie.

L'intervention de l'éducation thérapeutique peut également concerner l'entourage, surtout lors de pathologies psychiatriques. Les étapes de l'éducation thérapeutique sont d'abord l'élaboration d'un diagnostic éducatif et non pas diagnostic maladie. Ce diagnostic est indispensable à la connaissance du patient, à l'identification de ses besoins et de ses attentes et à la formulation avec lui des compétences à acquérir ou à mobiliser.

C'est-à-dire de quoi ce patient a-t-il besoin pour bien vivre sa maladie. L'objectif principal de cette étape est de savoir comment le patient vit avec sa maladie et surtout comment il la perçoit. En effet, le diagnostic éducatif permet d'accéder aux connaissances qu'a le patient concernant sa maladie, qu'elle soit fausse ou vraie.

Il permet aussi d'accéder aux représentations de la maladie. Par exemple, chez plusieurs patients, la maladie cancéreuse représente la mort. Et, aux logiques explicatives de la maladie, dans beaucoup de situations, les patients expliquent les pathologies psychiatriques comme étant de l'ensorcellement, un mauvais œil, etc.

Le diagnostic éducatif permet aussi d'accéder au ressenti du patient, c'est-à-dire comment il ressent sa maladie. Il permet aussi de percevoir sa manière de réagir à sa situation, les diverses étapes de son évolution psychologique par rapport à sa maladie. Il favorise aussi l'implication du patient, soutient sa motivation pour le changement.

Rappelez-vous qu'on avait dit que la motivation ou l'entretien motivationnel est le cœur de l'éducation thérapeutique. Et il permet aussi de rechercher avec le patient les modalités de gestion personnelle de sa maladie qui sont les plus adaptées à sa situation. Deuxièmement, définir un programme personnalisé, c'est-à-dire formuler avec le patient les compétences à acquérir ou à mobiliser au regard de son projet, c'est-à-dire de quoi a-t-il besoin.

Cela nécessite planifier, organiser des séances d'éducation thérapeutique en individuel, en groupe ou en groupe. Il faut également planifier et mettre en œuvre les séances, et ce de façon pratique, avec horaire des séances, la durée, l'ordre de jour, etc. À la fin, il est impératif de réaliser une évaluation individuelle qui permet de faire le point avec le patient sur ce qu'il a compris, sur ce qu'il sait faire maintenant et comment il vit au quotidien avec sa maladie, sur ce qu'il lui reste éventuellement à acquérir comme compétences qu'on peut proposer dans une nouvelle offre d'éducation thérapeutique, en tenant compte des résultats de l'évaluation de l'éducation thérapeutique actuelle.

Les techniques les plus utilisées, comme on pouvait très bien facilement le déduire, si les techniques de communication sont très sur le patient, on avait vu déjà dans la définition de l'OMS que l'éducation thérapeutique est centrée sur le malade, et l'entretien motivationnel, comme on a vu dans les chapitres précédents. Comment se déroule de façon pratique une séance d'éducation thérapeutique? D'abord, il faut préciser le cadre, c'est-à-dire présenter les participants, que ce soit les soignants, les patients, faire un rappel des règles éthiques, c'est très important, c'est impératif, qu'il n'y ait pas de jugement de la part ni des soignants, ni des patients entre eux. Écoute et respect de la parole de l'autre, et respecter les termes de confidentialité, c'est-à-dire ne pas divulguer les informations traitées au cours de la séance.

L'équipe soignante a un rôle important dans la valorisation du patient. Comment on valorise le patient? On reformule ses propos pour lui signifier l'importance de sa parole, on relance la discussion à partir des paroles du patient, et on laisse la séance se dérouler selon le rythme qu'on appelle le rythme du groupe. Les soignants doivent avoir une attitude empathique et bienveillante envers tous les participants.

En conclusion des séances, comme on a dit, l'animateur va utiliser une technique qui est très importante en communication, qui est le résumé. Cela permet de mettre en exergue, en évidence, les principales informations, les principales techniques qu'on a acquis au cours de la séance d'éducation thérapeutique, avec un tour de table qui est proposé où chaque participant indique ce qu'il a marqué au cours de la réunion et comment il se sent à l'issue de cette séance. Pour être de qualité, l'éducation thérapeutique du patient doit être centrée sur le patient, chose de très important, vous le comprenez maintenant très bien, doit être élaborée par le patient, avec le patient et impliquant autant que possible les proches qui jouent un rôle important dans la prise en charge des maladies chroniques.

Elle doit être issue d'une évaluation des besoins du malade, c'est-à-dire le diagnostic éducatif et de l'environnement du patient. Elle doit être réalisée par des professionnels de santé formés en la matière, définies en termes d'activités et de contenus, organisées dans le temps, c'est-à-dire elles doivent être structurées, on ne laisse rien au hasard. Et surtout, c'est une activité qui doit être évaluée pour pouvoir améliorer si besoin.

En conclusion, les pratiques d'éducation thérapeutique sont récentes, visant à limiter les complications, les handicaps et même à diminuer les décès prématurés. Par conséquent, pratiquer l'éducation thérapeutique diminue les dépenses en termes de santé. Et je vous remercie.

Chers étudiants, j'ai le plaisir de vous retrouver encore une fois pour traiter une situation de communication clinique spécifique et la gestion des émotions et qui vient compléter notre cours sur l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Les objectifs du cours sont caractériser les émotions, décrire l'intérêt de la gestion des émotions dans la relation de soins et décrire un modèle de gestion des émotions. Une émotion est une sensation plus ou moins nette de plaisir ou de déplaisir, que l'on peut reconnaître en soi ou prêter aux autres par extrapolation.

Il s'agit d'une notion complexe car elle comporte un aspect psychique ou mental, c'est-à-dire ce qu'on ressent, la joie, le chagrin et autres, et un aspect physique, ce sont les manifestations physiologiques de l'émotion. Les relations médecins-malades peuvent être sources d'émotions car le patient peut exprimer des souffrances et se créer, se confier à son médecin. Le médecin n'est pas à l'abri de des charges émotionnelles, angoisses, doutes, dans une relation qui est très exigeante.

Parfois c'est une relation conflictuelle d'omblet ou mal ressentie. Elle est toujours différente d'un malade à l'autre, d'une famille à l'autre, d'un moment à l'autre, c'est ce qui fait la complexité de la relation médecin-malade. Je vous ai mis ici plusieurs émotions, plusieurs expressions faciales des émotions.

Je vous demande de ne pas lire l'émotion et d'essayer de déduire vous-même les différentes émotions sur cette diapositive. On va traiter ça dans la séance interactive. Il y a six types d'émotions simples qui sont relatives essentiellement à la survie de l'individu.

La colère, la joie, le dégoût, la surprise, la tristesse et la peur. On décrit aussi ce qu'on appelle les émotions secondaires, c'est l'association d'émotions simples. Par exemple, la honte est l'association de la colère plus la peur.

À quoi servent les émotions ? Les émotions, et particulièrement celles de l'excitation, de la colère et la peur, correspondent à un réflexe naturel qui permet aux êtres vivants de devenir momentanément plus forts et plus rapides devant ce qui les met en danger. Plusieurs théories ont été mises pour expliquer l'origine des émotions, notamment la théorie cognitive,

physiologiste, évolutionniste et autres. Je vous ai choisi une technique simple.

Il y a plusieurs techniques de gestion des émotions, mais dans ce cours-là, je vous ai choisi une technique plutôt simple de gestion des émotions. C'est le modèle NURSE. N pour Naming, U pour Understanding, R pour Respecting, S pour Supporting et E pour Exploring.

On va détailler chaque étape. D'abord, Naming, c'est-à-dire nommer les émotions. Le fait de mettre un nom sur l'émotion consiste à reformuler, c'est-à-dire utiliser la technique de reformulation.

Le sentiment éprouvé par le patient est nommé tel qu'il est perçu. Cette étape est pertinente lorsque le patient n'a pas déjà exprimé lui-même ses sentiments. Le fait de nommer les sentiments permet de diminuer l'intensité de l'émotion.

Understanding, c'est exprimer de la compréhension pour les émotions du patient et pour son vécu, tout particulièrement dans les cas où les patients relâchent des situations de vie difficiles. Il est toujours possible de valoriser les efforts qu'il déploie pour s'en sortir. Troisièmement, il faut exprimer du respect, de la reconnaissance pour le patient.

Quatrièmement, apporter son soutien au patient. Et à la fin, investiguer d'autres aspects propres aux émotions. Cette investigation est particulièrement conseillée lorsque le médecin ne perçoit pas l'état émotionnel du patient de façon claire.

Et je vous invite à revenir à la deuxième diapositive où je vous ai mis les différentes émotions. Je vous ai donné ici un exemple du modèle NURSE qu'on pourrait traiter dans les séances interactives. En conclusion, l'appréhension et les difficultés éprouvées par les médecins vis-à-vis de la gestion des réactions émotionnelles des patients à cause de leur manque de formation à la question.

Il faut apprendre à gérer les réactions émotionnelles des patients et ce par l'acquisition de stratégies de soutien, reconnaissance, empathie et réassurance. Chers étudiants, j'ai le plaisir de vous présenter encore une fois une autre situation de communication clinique spécifique en matière de santé, c'est l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Les objectifs du cours sont définir une mauvaise nouvelle, décrire l'impact d'une bonne information sur les réactions émotionnelles du patient, décrire les réactions émotionnelles des médecins suite à l'avance et enfin décrire une procédure pour annoncer une mauvaise nouvelle.

Dans la littérature scientifique, beaucoup de recherches concernent l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Déjà, c'est quoi la définition d'une mauvaise nouvelle ? Il s'agit d'un concept qui renvoie à un jugement de valeur porté par le patient sur une situation perçue comme sans espoir, menaçant son bien-être physique et ou mental, risquant de bouleverser son quotidien et l'obligeant à s'orienter vers de nouveaux choix de vie. La vie avant l'annonce de cette mauvaise nouvelle est différente de la vie après l'annonce.

La mauvaise nouvelle se définit a posteriori lorsqu'elle entraîne un déficit cognitif, comportemental ou émotionnel chez le patient qui persiste après l'annonce. Exemple de mauvaise nouvelle, maladie à pronostic défavorable comme le cancer, une amputation, l'annonce d'un handicap important lors d'une naissance et autres. L'évaluation d'une mauvaise nouvelle est subjective, elle est faite par le médecin et son patient.

Une annonce de mauvaise nouvelle est inévitablement un traumatisme. Par exemple, l'idée d'avoir un cancer induit une détresse psychologique. Le sujet est confronté à son futur et sa durée de vie.

Une transmission empathique d'une mauvaise nouvelle peut réduire le risque de traumatisation secondaire. Quels sont les objectifs de l'annonce ? Réduire, comme on a dit, le risque de traumatisation et de souffrance psychique du patient et transmettre des informations qui permettent une adaptation et une adhésion de celui-ci à son traitement. Quel est l'impact émotionnel de l'annonce d'une mauvaise nouvelle ? D'abord, quelles sont les réactions émotionnelles du patient ? Des facteurs liés à la situation et à la personnalité du malade influencent ces réactions.

En général, l'anxiété des patients diminue après un entretien avec le médecin. Les défenses psychologiques ont pour objectif de réduire l'intensité, la fréquence et la durée de la souffrance émotionnelle. Beaucoup de mécanismes de défense sont élaborés pour se protéger d'une réalité jugée trop douloureuse pour le malade.

Les mécanismes de défense sont multiples et sans d'intensité variable. Je vous demande de vous référer à vos cours de psychologie. De nombreuses classifications sont proposées des différents mécanismes de défense.

Je vous ai donné ici un exemple sur le déni. Le déni consiste à rejeter en totalité ou partiellement le contenu de l'information reçue et ses conséquences. Le patient réagit de telle sorte qu'il donne l'impression de ne pas avoir entendu l'annonce ou bien il va nier l'information médicale, évoquant une erreur médicale par exemple.

Il existe un consensus selon lequel l'information devrait avoir au moins une fonction essentielle, c'est réduire le sentiment pénible d'incertitude et l'anticipation. L'information peut corriger, dédramatiser le caractère létal associé souvent à une pathologie, par exemple le cancer, par une remise en question des croyances du malade. Les informations transmises ont également comme fonction d'améliorer la relation médecin-malade.

L'information a également comme fonction d'amener le malade à un traitement curatif ou palliatif, susceptible de lui être bénéfique. Le médecin est tenu de transmettre une information claire et objective au patient, tout en laissant la place à l'espoir. Et telle est la difficulté de l'annonce d'une mauvaise nouvelle.

Il est contraint d'endosser le rôle de messenger de mauvaise nouvelle, donc c'est normal qu'il ait des réactions émotionnelles face à l'annonce. D'abord, la première réaction c'est la peur de l'annonce, la peur de faire mal à son malade, la peur d'être tenu pour responsable, la peur de ne pas savoir transmettre l'information, d'être maladroit, la peur des réactions émotionnelles incontrôlables des patients et la peur d'exprimer ses propres émotions. La deuxième réaction émotionnelle des médecins, c'est le sentiment d'échec, la culpabilité, la tristesse.

Face à ces réactions émotionnelles, les médecins développent aussi des mécanismes de défense. Par exemple, le mensonge. Le médecin dissimulera la découverte de métastases à son patient à un stade avancé de la maladie, souvent employé avec le prétexte de vouloir protéger son patient.

La fausse réassurance, le médecin maintient le patient dans de faux espoirs. La rationalisation, le médecin va adopter un discours scientifique usant deux mots techniques incompréhensibles pour le patient. La banalisation ou la distanciation, le soignant ne se focalise que sur la douleur physique du patient, négligeant totalement sa souffrance psychique.

Et l'évitement, qui est traduit par des comportements de fouille du médecin vis-à-vis de son patient. Il va remporter par exemple la consultation d'annonce. J'ai choisi une procédure simple pour annoncer une mauvaise nouvelle, c'est la procédure BAD.

C'est une procédure qui tient compte de la réalité clinique et qui inclut les techniques de base de la communication qu'on a vu ultérieurement. Structurer d'abord l'entretien, transmettre les informations de façon claire et gérer les émotions. La chronique BAD correspond B pour Breaking Bad News, A pour Acknowledge Patient's Reactions et D pour Develop Plans for the Near Future.

D'abord, Breaking Bad News, transmettre l'information. Il faut d'abord se poser la question, que sait le patient sur sa maladie? Il est conseillé de demander au patient, pouvez-vous me dire brièvement ce que vous savez sur votre maladie, avant d'annoncer la mauvaise nouvelle. Les connaissances qu'ont le patient de leur maladie peuvent parfois être erronées.

Il est fréquent que les expériences passées, par exemple une infection cancéreuse ayant touché un proche, ait généré des croyances diverses qui ne concordent pas toujours avec la réalité médicale. Deuxièmement, annoncer. Je suis désolé et on annonce de façon claire.

L'annonce permet de focaliser l'attention du patient sur ce qui va suivre. Parfois, le patient anticipe déjà la mauvaise nouvelle. Il va vous dire, est-ce que le cancer est revenu, est-ce que la tumeur est revenue? Il faut savoir que la transmission non verbale, les techniques de communication non verbale d'information, par son caractère hautement ambigu et donc potentiellement interprétable, peut entraîner un état de détresse.

Donc là, les méthodes de communication non verbale sont à éviter lors de l'annonce d'une

mauvaise nouvelle. Troisièmement, information claire et précise comme on a dit tout à l'heure. Keep it short and simple.

La plupart des mauvaises nouvelles peuvent être annoncées brièvement et avec simplicité et clarté. Les médecins en fait qui parlent beaucoup et utilisent un langage compliqué vont satisfaire davantage leurs propres besoins que ceux des patients. Après, il faut donner un ton de pause au patient pour lui permettre de réagir et d'exprimer ses besoins immédiats et de lui permettre de réaliser la mauvaise nouvelle.

En fonction de la réaction du patient, le médecin répondra plutôt à ses émotions ou à ses besoins d'information, en utilisant soit la technique de gestion des émotions soit la technique de réconfort. Le réconfort est important lorsqu'il est porteur d'espoir, mais si le réconfort est apporté précocement, les patients se trouvent privés de temps nécessaire pour prendre conscience de leur inquiétude et pour identifier les informations dont ils ont besoin dans l'immédiat. Il faut annoncer la stratégie thérapeutique à court terme, c'est à dire quelles sont les prochaines étapes.

Le patient doit être informé des prochaines étapes, par exemple en premier lieu on doit opérer puis on décidera après des autres démarches. Fixer un rendez-vous et assurer sa disponibilité en cas d'urgence, c'est très important pour votre patient. Une consultation d'annonce a besoin de conditions matérielles précises.

Le rendez-vous doit être organisé sans mise en scène excessive pour éviter de majorer l'anxiété, dans un délai acceptable en tenant compte du fait que la détresse psychique du patient et l'anticipation est une urgence. Proposer au patient s'il le souhaite d'être accompagné d'un proche. L'environnement doit être calme, pas de téléphone, pas de dérangement lors de l'entretien.

S'asseoir pour parler avec votre malade en face à face. Prendre le temps, c'est un entretien qui doit être dédié spécifiquement à l'annonce et à la discussion. C'est un schéma qui résume la conduite à tenir devant une mauvaise nouvelle ou comment faire l'annonce d'une mauvaise nouvelle.

Je vous ai mis ici des exemples d'annonces d'une mauvaise nouvelle qu'on pourrait discuter lors des séances interactives. En conclusion, il n'y a pas une annonce mais une succession d'annonces parce qu'il s'agit d'un processus thérapeutique long et ce sont des annonces qui se font au rythme des patients. Je vous remercie.

Chers étudiants, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce cours faisant partie des situations de communication clinique spécifique qui est la gestion des entretiens triangulaires. L'influence sur la communication de la présence d'une troisième personne ou bien de la famille du malade lors de consultations est très peu étudiée. Cependant, 20% des personnes de plus de 65 ans sont accompagnées quand elles rendent visite à leur médecin et 21% des patients ayant un cancer sont accompagnées indépendamment de leur âge ou de leur sexe.

L'étude de la relation triangulaire et de l'entretien systémique est encore très peu développée en médecine. En effet, l'alliance avec le proche accompagnant peut se révéler particulièrement judicieux pour le patient et pour le soignant et ce dans le cadre d'une prise en charge collective. Le plus souvent, il est en effet un témoin privilégié de la vie quotidienne du patient et de ses modes d'adaptation face à la maladie.

Une des premières variables à prendre en compte est le lien de parenté qui unit le malade à la personne qui l'accompagne. L'accompagnant sera le plus fréquemment le conjoint du patient. Moins fréquemment et de manière équivalente, il s'agira d'un enfant, d'un parent ou d'un membre de la fratrie.

Cet accompagnant est très souvent le preneur en charge primaire du patient, c'est-à-dire c'est celui qui s'en occupe le plus. La présence d'un proche en consultation est plus fréquente lorsque la situation médicale est difficile, maladie grave ou bien lors des premières consultations. Le patient se tourne vers sa famille quand son état se dégrade pour trouver une aide psychologique et aussi matérielle.

Cet accompagnement peut aussi servir la famille en diminuant sa propre anxiété, ses incertitudes face à la maladie de son proche. La faiblesse du patient, son opposition au traitement ou le déni de la maladie sont d'autres cas de figure possible dans lesquels les soignants sont amenés à rencontrer les proches. Et l'épuisement émotionnel des proches est aussi une cause de leur présence dans les entretiens.

L'impact sur la communication. La présence d'une tierce personne introduit des modifications importantes dans l'interaction entre médecins et malades. D'abord, quels sont les avantages d'être accompagné ? Cela a un effet de soutien, encouragement pour le patient.

Cela l'aide à prendre des décisions, à verbaliser ses questions et ses inquiétudes. Permet au médecin de récolter des informations supplémentaires et aide le malade à se rappeler des paroles du médecin et à les interpréter. Cependant, quels sont les inconvénients d'être accompagné ? En fait, au lieu de soutenir le patient, l'accompagnant peut exprimer ses propres préoccupations et occulter celles du patient.

Il peut chercher à obtenir la certitude que les meilleurs soins sont prodigués ou que la bonne décision est prise. Ces différents objectifs peuvent amener le proche à dominer l'interaction pour aboutir à ses fins. Un deuxième inconvénient, c'est que cela empêche le patient d'exprimer ses craintes et parler librement et ouvertement de ses peurs pour ne pas perturber ses proches.

En outre, il ne peut pas communiquer sa perception de la situation, ses sentiments à son propre rythme. Les conséquences lors des entretiens triangulaires sur la longueur de la consultation, sur les objectifs du soignant ainsi que sur les stratégies de communication. D'abord, augmenter la durée de consultation alors que le médecin a déjà un horaire très chargé.

Plonger les soignants et plus particulièrement les médecins dans un dilemme. D'un côté, leur devoir est centré sur les soins, sur le bien-être de leurs patients. Et d'un autre côté, ils savent très bien que le contact avec la famille permet d'améliorer les conditions de vie du malade, d'encourager et de soutenir les efforts de la famille, de valoriser son aide pour le patient.

Donc, les soignants sont tiraillés entre les intérêts des deux parties, patients et entourage. Cela influence bien évidemment les stratégies de communication utilisées par les soignants. Quand un proche est présent, certains patients pourraient ne pas aborder leurs inquiétudes pour leur famille ou bien des questions relatives à la sexualité ou à d'autres domaines d'ordre intime.

Quelles sont les recommandations au cas de présence d'un proche? D'abord, faire connaissance. Identification de chaque personne présente, clarification du rôle de chacun par rapport au malade et reconnaissance du rôle important joué par les proches. Deuxièmement, clarifier les attentes des proches, clarifier la compréhension de chaque proche et clarifier les questions et les préoccupations de chaque proche.

Troisièmement, clarifier les attentes du patient, ses préoccupations, les questions relatives à sa maladie, évaluation de ses priorités, par quelles questions commence-t-on, évaluer les questions que le patient souhaiterait clarifier en famille et celles qu'il souhaiterait clarifier seul avec son médecin. Quatrièmement, proposer un agenda, c'est-à-dire clarifier le but de la consultation. Qu'est-ce que le médecin doit faire? Il faut estimer aussi le temps nécessaire pour répondre aux questions et les préoccupations de chacun et reconnaître si nécessaire la difficulté de répondre à toutes les questions.

En conclusion, de nombreuses questions éthiques se posent aussi, c'est-à-dire dans quel cas une rencontre avec la famille est-elle conseillée? Quelle place les proches doivent-ils occuper dans le processus de soins? Je vous remercie. Chers étudiants, j'ai le plaisir de vous traiter aujourd'hui lors de ce cours. Une situation de communication clinique spécifique dans le domaine médical, c'est la communication en équipe.

Les objectifs du cours sont définir une équipe de soins, citer les caractéristiques d'une équipe de soins, citer et décrire les techniques de communication pour les équipes soignantes. Toutes les études récentes confirment que le travail en équipe et particulièrement la qualité de communication constituent une composante majeure dans la sécurité des soins. Dans un grand centre hospitalier, universitaire par exemple, on compte des équipes de médecins dans chaque spécialité, le personnel infirmier, les pharmaciens ainsi que les autres professionnels paramédicaux qui doivent tous coordonner les soins les uns avec les autres.

Donc déjà on introduit ici la notion d'hétérogénéité d'une équipe de soins. Selon les études, la qualité de communication au sein des équipes est minimale. Seule une partie des informations prioritaires ou importantes est échangée.

Elle est inadéquate par une mise en exergue d'informations non importantes, voire erronées. En chirurgie, ce taux s'élève, c'est-à-dire le taux de ces informations minimales et inadéquates, à 32%. En anesthésie, à 38%.

Et entre anesthésistes et chirurgiens, ce taux s'élève à 50%. Dans les pays industrialisés, on estime que 10% des patients sont victimes d'un événement indésirable durant leur séjour à l'hôpital, dont la moitié pourraient être évitées s'il y avait une communication efficace au sein d'une équipe médicale. De nombreuses études montrent, surtout en anesthésie, qu'une majorité de ces événements est le fruit de défaillances au niveau du travail en équipe.

Mauvaise dynamique du groupe, défaut de communication et autres. D'abord, c'est quoi une équipe de soins ? Il s'agit d'une équipe où les membres connaissent leur rôle et les rôles des autres membres et interagissent les uns avec les autres en vue d'atteindre un objectif commun. Ils prennent des décisions, ils possèdent des connaissances et compétences spécialisées et assument souvent une charge de travail importante.

Ils doivent agir comme un individu collectif. Il existe différents types d'équipes en soins en santé, les centres de soins ruraux, les équipes de salles d'accouchement, les services de soins intensifs et autres. Ces équipes peuvent être regroupées au même endroit ou dans des lieux différents.

Une équipe peut inclure une seule discipline ou impliquer des professionnels issus de plusieurs disciplines différentes. Il faut savoir que le patient et son entourage sont de plus en plus considérés comme des membres actifs de l'équipe soignante. Les rôles joués par les professionnels de santé varient entre les équipes ou au sein d'une même équipe selon les mouvements.

Cependant, de nombreuses équipes soignantes, les équipes d'urgence ou les équipes chirurgicales doivent travailler ensemble et être parfaitement opérationnelles sans avoir le temps de nouer des relations interpersonnelles. Certaines équipes ne sont pas très stables car leur composition change souvent. Et en plus, chaque membre de l'équipe a un niveau de connaissances et de compétences différents auxquels il faut s'adapter.

Quelles sont les caractéristiques d'une équipe, mais cette fois efficace ? Ils ont un but commun qui est clairement défini, caractérisé par des intérêts collectifs et un sentiment de responsabilité partagé. Ils ont des objectifs mesurables axés sur la tâche de l'équipe et un leadership efficace qui fixe et maintient les structures, gère les conflits, il est à l'écoute des membres, il leur fait confiance et leur apporte son soutien. Une équipe efficace a des méthodes de communication efficaces aussi.

C'est le partage d'informations qui se fait de façon rapide et régulière et on consacre du temps à la réflexion en équipe. Une bonne cohésion avec un engagement et esprit d'équipe et un respect mutuel. De bonnes compétences de communication sont les piliers de la sécurité des patients et

d'un bon travail d'équipe.

Les stratégies suivantes peuvent aider les membres de l'équipe à partager précisément les informations entre eux et à garantir que l'accent soit bien mis sur les informations importantes à communiquer. La méthode S A E D, S pour situation, A antécédent, E évaluation et D demande. C'est une technique qui permet de communiquer les informations essentielles sur les préoccupations à l'égard d'un patient qui nécessite une prise en charge et un traitement immédiat, c'est-à-dire en situation d'urgence.

S, quelle est la situation actuelle en ce qui concerne le patient. Exemple, je suis l'infirmière qui suit madame X, salle X, lit numéro X. Elle se plaint principalement d'une dyspnée d'apparition récente. A pour l'antécédent, quels sont les antécédents utiles mais qui sont liés au contexte.

La patiente est une femme de 62 ans, premier jour post-opératoire après une chirurgie abdominale, elle ne présente aucun antécédent de maladie cardiaque ou pulmonaire. Là vous avez vu que l'infirmière a regroupé les antécédents les plus importants pour la patiente. E pour évaluation, quelle est mon évaluation de l'état actuel de la patiente.

Donc l'examen montre que les bruits respiratoires sont diminués du côté droit et que la patiente dit avoir mal. Donc j'aimerais éliminer un pneu motorax qui est une urgence. D, quelle est ma demande.

Je crois vraiment que la patiente doit être examinée maintenant. Pouvez-vous venir immédiatement. Deuxième technique, c'est les annonces.

Les annonces sont le moyen de communiquer les informations importantes ou les critiques à tous les membres de l'équipe simultanément lors de situations nouvelles. Cette technique aide les membres de l'équipe à anticiper les étapes suivantes. Exemple annonce entre un chef d'équipe et un interne.

Chef d'équipe, voie aérienne, interne, voie aérienne dégagée. Chef d'équipe, bruit respiratoire, interne, bruit respiratoire diminué côté droit, etc. Troisième technique, c'est la communication en boucle fermée.

C'est une technique simple pour garantir que les informations énoncées par l'expéditeur soient bien comprises par le destinataire. Étape 1, l'expéditeur initie le message. Étape 2, le destinataire accepte le message et on en répète le contenu.

Étape 3, l'expéditeur vérifie l'exactitude du message répété pour confirmer qu'il a été bien compris. Exemple médecin, administrez 20 mg de prednisolone en bolus intraveineux. L'expéditeur initie le message.

L'infirmière, 20 mg de prednisolone en bolus IV. Le destinataire accepte le message, il le répète. Médecin, oui.

C'est la troisième étape. L'expéditeur vérifie l'exactitude du message répété pour confirmer qu'il a été bien compris. La résolution des désaccords et des conflits.

Les conflits et les désaccords sont très fréquents chez les équipes soignantes pour toutes les raisons qu'on a citées tout à l'heure. La première cause, c'est l'hétérogénéité des rôles et l'ambiguïté des rôles parfois de certains membres de l'équipe. La résolution des accords est délicate pour les membres les moins expérimentés de l'équipe, tels que les étudiants ou dans des équipes qui sont connues par le fait d'être très hiérarchisées par nature, c'est-à-dire qu'ils adoptent une relation de communication asymétrique.

Il est toutefois important que tous les membres de l'équipe se sentent libres de signaler tout élément qui peut, selon eux, avoir une incidence sur la sécurité du patient. Comment on peut résoudre les désaccords et les conflits ? Je vous ai choisi la méthode DESC. C'est un processus constructif de résolution de conflits.

Le objectif est de parvenir à un consensus. D pour décrire la situation ou le comportement spécifique et fournir les données ou les éléments de preuves concrets. E exprimer son ressenti face à la situation ainsi que ses préoccupations.

S suggérer des alternatives et rechercher un accord. S pour suggérer. Les conséquences doivent être énoncées en termes d'effets sur les objectifs définis de l'équipe et ou la sécurité des patients.

La méthode SUS, CUS, pardon, est l'abréviation désignant un processus en trois étapes visant à aider une personne à mettre fin à une activité problématique. C, I'm concerned, je suis préoccupé. U, uncomfortable, je suis très mal à l'aise par rapport à la situation.

D, this is a safety issue, c'est une question de sécurité. En conclusion, développer le savoir-faire du travail en équipe où la communication s'inscrit en première ligne contribue fortement à l'amélioration des sécurités des soins. Je vous remercie.